

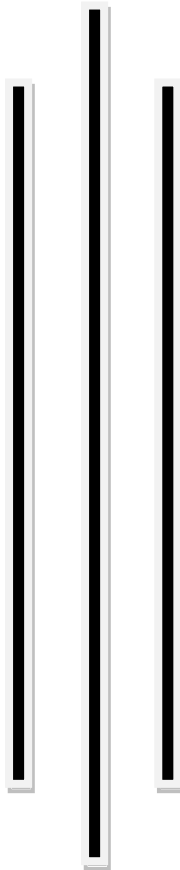
JUDUL

KONSEP DAN PROSEDUR

KETERAMPILAN DASAR TINDAKAN KEPERAWATAN

Kompetensi Keahlian Layanan Penunjang Keperawatan Dan Caregiving

SMK/MAK Fase F (Kls XI & Kls XII)



Disusun Oleh

Dewi Rasilian, S.Kep., Ns

Wawan Kurniawan R, S.Kep., Ns

Milda Laila Taufik, S.Kep., Ns

Nur Sri Wulandari, S.ST

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat Anugerahnya penulis mampu menyelesaikan buku yang berjudul Konsep Dan Prosedur Keterampilan Dasar Tindakan Keperawatan ini, buku ini disusun berdasarkan materi dan capaian kompetensi yang merujuk pada Kepmenaker RI Nomor 28 Tahun 2021 Penetapan SKKNI Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Kesehatan Manusia Bidang Caregiver lanjut usia dengan mempertimbangkan deskriptor jenjang kualifikasi 2 pada KKNi, untuk meningkatkan kompetensi siswa dari sisi pengetahuan, keterampilan dan sikap secara utuh.

Buku Konsep Dan Prosedur Keterampilan Dasar Tindakan Keperawatan ini, merupakan salah satu sumber pengetahuan tentang bagaimana konsep dan prosedur keterampilan dasar tindakan keperawatan secara baik dan benar sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) keterampilan dasar tindakan keperawatan pada layanan kesehatan.

Buku ini merupakan salah satu upaya yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan, dengan memberikan buku pegangan pada peserta didik, agar peserta didik memiliki kemampuan melakukan pelayanan prima dan esensial terhadap individu, keluarga, dan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan klien untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.

Kiranya apa yang dituangkan dalam buku ini sudah berpedoman pada capaian pembelajaran elemen keterampilan dasar layanan penunjang keperawatan dan caregiving. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan baik isi maupun kalimat, mohon berkenan memberikan saran untuk perbaikan berikutnya.

Penulis

A. Capaian Pembelajaran Elemen Keterampilan Dasar Layanan Penunjang Keperawatan Dan Caregiving SMK/MAK Fase F (Kls XI & Kls XII (Berdasarkan kurikulum merdeka)

Elemen	Capaian Pembelajaran
Keterampilan dasar layanan penunjang keperawatan dan <i>caregiving</i> sesuai tahapan usia	Peserta didik mampu menerapkan keterampilan dasar tindakan keperawatan sesuai tahapan usia yang meliputi desinfeksi, sterilisasi serta penyimpanan alat kesehatan, dan penyiapan tempat tidur, menerapkan pertolongan personal hygiene, pertolongan pengubahan posisi klien, pertolongan mobilisasi dan ambulasi klien, pemberian makan minum per oral, pemberian makan melalui selang nasogastric, pertolongan eliminasi BAK dan BAB, perawatan kateter, perawatan vulva dan perineum, pertolongan latihan nafas dalam dan batuk efektif, pemasangan buli-buli panas dan kirbat es, melaksanakan kompres hangat dan dingin pemberian obat (oral, tetes, topical, suppositoria) dan perawatan disabilitas.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	
CAPAIAN PEMBELAJARAN.....	
BAB I Sterilisasi, Disinfeksi Dan Penyimpanan Alat Kesehatan.....	
1.1. Desinfeksi.....	
1.2. Sterilisasi.....	
1.3. Prinsip Aseptik Dan Antiseptik Pada Alat Kesehatan.....	
1.4. Pemeliharaan Alat Kesehatan.....	
1.5. Prosedur Tindakan Perawatan Alat Kesehatan.....	
BAB 2 Penyiapan Tempat Tidur Pasien.....	
2.1. Menyiapkan Tempat Tidur.....	
2.2. Syarat-Syarat Tempat Tidur Dalam Perawatan Kesehatan.....	
2.3. Jenis-Jenis Tempat Tidur.....	
2.4. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Perawatan Tempat Tidur.....	
2.5. Mengganti Linen Dengan Pasien Diatas Tempat Tidur.....	
BAB 3 Pertolongan Pengubahan Posisi Klien.....	
3.1. Pengertian Memposisikan klien.....	
3.2. Macam-Macam Posisi.....	
3.3. Prosedur Tindakan Memposisikan Klien.....	
BAB 4 Pertolongan Ambulasi Pasien.....	
4.1. Pengertian Ambulasi	
4.2. Manfaat Ambulasi.....	
4.3. Alat Yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Ambulasi.....	
4.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Ambulasi.....	
4.5. Prosedur Tindakan Ambulasi.....	
BAB 5 Pertolongan Mobilisasi Pasien.....	
5.1. Pengertian Mobilisasi.....	
5.2. Tujuan Mobilisasi.....	
5.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mobilisasi.....	
5.4. Jenis Mobilitas Dan Imobilitas.....	
5.5. Dampak Imobilitas.....	
5.6. Mobilisasi Dengan Memberikan Posisi Miring.....	
BAB 6 Pertolongan personal hygiene	
6.1. Pengertian Personal Hygiene.....	
6.2. Tujuan dari personal hygiene.....	
6.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Personal Hygiene.....	
6.4. Pelaksanaan Personal Hygiene.....	
6.5. Macam-Macam Personal Hygiene.....	
BAB 7 Pemberian Nutrisi Pasien	
7.1. Pemberian Nutrisi Pasien Per Oral.....	
7.2. Pemberian Makan Melalui Selang Nasogastrik (NGT).....	
BAB 8 Membantu Pasien Bak Dan BAB.....	
8.1. Membantu Pasien Bak Dan BAB.....	
8.2. Membantu Pasien Bak Dan BAB.....	

BAB 9 Perawatan Kateter.....	
9.1. Pengertian Perawatan kateter.....	
9.2. Tujuan Perawatan kateter.....	
9.3. Indikasi Perawatan kateter.....	
9.4. Tindakan Perawatan Kateter.....	
BAB 10 Latihan Napas Dalam Dan Batuk Efektif.....	
10.1. Pengertian Latihan Napas Dalam dan Batuk Efektif.....	
10.2. Tujuan Latihan Napas Dalam dan Batuk Efektif	
10.3. Indikasi Latihan Napas Dalam dan Batuk Efektif.....	
10.4. Tindakan Latihan Napas Dalam dan Batuk Efektif.....	
BAB 11 Pemberian Kompres Pada Pasien.....	
11.1. Pengertian Kompres	
11.2. Jenis-jenis Kompres.....	
11.3. Tujuan Kompres.....	
11.4. Indikasi Kompres.....	
11.5. Prosedur Tindakan Kompres.....	
BAB 12 Pemberian Obat.....	
12.1 Pengertian Obat.....	
12.1. Cara Penggunaan Obat.....	
12.2. SOP Prosedur Tindakan Pemberian Obat.....	
BAB 13 Perawatan Untuk Penyandang Disabilitas.....	
13.1. Pengertian Perawatan Disabilitas.....	
13.2. Tujuan Perawatan Disabilitas.....	
13.3. Faktor Penyebab Disabilitas.....	
13.4. Jenis- Jenis Disabilitas.....	
13.5. Jenis-Jenis Perawatan Disabilitas	
13.6. Prinsip Perawatan Disabilitas.....	

BAB I

STERILISASI, DISINFEKSI DAN PENYIMPANAN ALAT KESEHATAN

1.1. Desinfeksi

Desinfeksi adalah tindakan membunuh mikroorganisme patogen atau apatogen, tetapi tidak membunuh spora yang terdapat dalam alat-alat perawatan atau permukaan jaringan. Bertujuan untuk mencegah terjadinya infeksi pada tindakan invasi serta mengondisikan alat dalam keadaan siap pakai.

1. Cara Desinfeksi :

a. Desinfeksi dengan cara mencuci

1. Cuci peralatan yang kotor dengan sabun, kemudian bersihkan dan basahi dengan alkohol 70%
2. Bersihkan luka kotor dengan menyiram luka dengan perhidol atau H₂O₂ 3%, betadine, atau larutan antiseptik lainnya
3. Bersihkan kulit atau jaringan tubuh yang akan dioperasi dengan yodium tinctura 3%, kemudian dengan alkohol 70%
4. Bersihkan vulva dengan larutan sublimat 1/1.000, PK (Permanganas Kalikus) 1/1.000, atau larutan sejenisnya.

b. Desinfeksi dengan cara mengoleskan

1. Oleskan luka dengan merkurokrom atau bekas luka jahitan menggunakan alkohol 70% atau betadine

c. Desinfeksi dengan cara merendam

1. Rendam tangan dengan larutan lysol 0,5%
2. Rendam peralatan dengan Lysol 3-5% selama 2 jam
3. Rendam alat tenun dengan Lysol 3-5% selama sekitar 24

d. Desinfeksi dengan cara menjemur

1. Jemur kasur, alat tenun, bantal, tempat tidur, dan peralatan (misalnya urinal dan pispot) di bawah sinar matahari selama dua jam untuk setiap permukaan

2. Cara Membuat Larutan Desinfektan :

a. Larutan sabun

- 1) Sabun padat/krim/cair
- 2) Gelas ukur
- 3) Timbangan
- 4) Alat pengocok
- 5) Air panas/hangat
- 6) Baskom

Prosedu kerja :

- 1) Membuat larutan sabun dari abu padat atau krim
 - a) Masukkan 4 gram sabun padat atau krim ke dalam 1 liter air panas/hangat. Aduksampai larut
- 2) Membuat larutan sabun dari sabun cair
 - a) Masukkan 3 mL sabun cair ke dalam 1 liter air panas/hangat. Aduk sampai larut Larutan sabun dapat digunakan untuk mencuci tangan dan peralatan medis, misalnya peralatan dari logam, kaca, dan plastik.

b. Lysol dan Creolin

Alat dan bahan:

- 1) Larutan Lysol atau Creolin
- 2) Gelas ukur
- 3) Baskom
- 4) Air

Prosedur kerja :

- 1) Membuat larutan Lysol atau Creolin 0,5%
 - a) Campurkan 5 mL Lysol atau Creolin ke dalam 1 liter air. Larutan Lysol 0,5% dapat digunakan untuk mencuci tangan, sedangkan larutan Creolin 0,5% dapat digunakan untuk mendesinfeksi lantai.
- 2) Membuat larutan lysol atau creoli 1%-3%
 - a) Campurkan Lysol atau Creolin sebanyak 10 mL (untuk larutan 1%), 20 mL (untuk larutan 2%), atau 30 mL (untuk larutan 3%) ke dalam 1 liter air. Larutan Lysol 1% dapat digunakan untuk mendesinfeksi peralatan medis. Larutan Lysol 2%-3% dapat digunakan untuk merendam peralatan yang digunakan oleh pasien berpenyakit menular selama 24 jam.

c. Savlon

Alat dan bahan :

- 1) Savlon
- 2) Gelas ukur
- 3) Baskom
- 4) Air

Prosedur kerja :

- 1) Membuat larutan Savlon 0,5%
 - a) Larutkan Savlon sebanyak 5 mL ke dalam 1 liter air. Larutan ini dapat digunakan untuk mencuci tangan
- 2) Membuat larutan Savlon 1%
 - a) Larutkan Savlon sebanyak 10 mL ke dalam 1 liter air. Larutan ini dapat digunakan untuk merendam peralatan medis

1.2. Sterilisasi

a. Jenis peralatan yang disterikan antara lain sebagai berikut

- 1) Peralatan logam, contohnya pinset, gunting, dan spekulum
- 2) Peralatan kaca, contohnya sepi (suit) dan tabung kimia
- 3) Peralatan karet, contohnya kateter, sarung tangan, pipa lambung, dan drain
- 4) Peralatan ebonit, contohnya kanule rektum dan kanul trakea
- 5) Peralatan email, contohnya bengkok (nierbekken) dan baskom
- 6) Peralatan porselen, contohnya mangkok, cangkir, dan piring
- 7) Peralatan plastik, contohnya slang infus
- 8) Peralatan tenun, contohnya kain kasa, tampon, dek operasi, baju, dan sarung tangan

b. Prosedur kerja

- 1) Bersihkan peralatan yang disterikan
- 2) Beri label pada peralatan yang dibungkus
- 3) Lakukan sterilisasi dengan salah satu cara berikut ini

a) Sterilisasi dengan cara rebus

Rebus peralatan dalam air mendidih (100°C) selama 15-20 menit. Peralatan yang disterilkan dengan cara ini antara lain adalah peralatan dari logam, kaca, dan karet.

b) Sterilisasi dengan cara stoom

Sterilkan peralatan dengan uap panas di dalam autoklaf dengan waktu, suhu, dan tekanan tertentu. Contohnya peralatan yang dapat disterilkan dengan cara ini adalah alat tenun

c) Sterilisasi dengan cara panas kering

Sterilkan peralatan dengan panas kering menggunakan oven panas tinggi. Peralatan yang dapat disterilkan dengan cara ini antara lain peralatan logam tajam dan peralatan dari kaca

d) Sterilisasi dengan menggunakan bahan kimia

Sterilkan peralatan dengan menggunakan bahan kimia, misalnya alkohol, sublimat, dan uap formalin. Peralatan yang dapat disterilkan dengan cara ini antara lain peralatan yang cepat rusak jika terkena panas, misalnya sarung tangan dan kateter

e) Sterilisasi dengan cara radiasi. Prinsipnya adalah radiasi menembus dinding sel dengan langsung mengenai DNA dari inti sel sehingga mikroba mengalami mutasi. Digunakan untuk sterilisasi bahan atau produk yang peka terhadap panas (termolabil). Ada dua macam radiasi yang digunakan yakni gelombang elektromagnetik (sinar X dan sinar γ) dan arus partikel kecil (sinar α dan β)

1.3. Prinsip Aseptik Dan Antiseptik Pada Alat Kesehatan

a. Aseptik

Aseptik adalah mencegah terjadinya kontaminasi oleh mikroorganisme pada jaringan bahan dan alat steril

Prinsip-Prinsip tindakan aseptik yang umum :

Semua benda yang menyentuh kulit yang luka atau dimasukkan ke dalam kulit untuk menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuh, atau yang dimasukkan ke dalam rongga badan yang dianggap steril haruslah steril.

- 1) Jangan sekali-kali menjauhi atau membelakangi tempat yang steril.
- 2) Peganglah objek-objek yang steril, setinggi atas pinggang dengan demikian objek-objek itu selalu akan terlihat jelas dan ini mencegah terjadinya kontaminasi diluar pengawasan.
- 3) Hindari berbicara, batuk, bersin atau menjangkau suatu objek yang steril.
- 4) Jangan sampai menumpahkan larutan apapun pada kain atau kertas yang sudah steril.
- 5) Bukalah bungkus yang steril sedemikian rupa, sehingga ujung pembungkusannya tidak mengarah pada si petugas.
- 6) Objek yang steril menjadi tercemar, jika bersentuhan dengan objek yang tidak steril.
- 7) Cairan mengalir menurut arah daya tarik bumi, jika forcep dipegang sehingga cairan desinfektan menyentuh bagian yang steril, maka forcep itu sudah tercemar.

b. Antiseptik

adalah Agen kimia yang mencegah, memperlambat atau menghentikan pertumbuhan mikroorganisme (kuman) pada permukaan tubuh dan membantu mencegah infeksi.

Penggunaan desinfektan/antiseptic :

- 1) Desinfeksi kulit secara umum (Pre Operasi) dengan larutan savlon 1:30 dalam alkohol 70%. Hibiscrup 0,5% dalam alkohol 70%.
- 2) Desinfeksi tangan dan kulit dengan Chlorrhexidine 4% (hibiscrup) minimal 2 menit
- 3) Untuk kasus Obgin (persiapan partus, vulva hygiene, neonatal hygiene). Hibiscrup 0,5% dalam Aquadest Savlon 1:300 dalam aqua hibiscrup

1.4. Pemeliharaan Alat Kesehatan

Melaksanakan pemeliharaan alat-alat keperawatan dan alat-alat kedokteran dengan cara membersihkan, mendesinfektan, menyeterilkan dan menyimpannya

Tujuan

Sebagai acuan untuk pemeliharaan alat medis dan keperawatan

- a. Menyiapkan peralatan perawatan dan kedokteran dalam keadaan siap pakai.
- b. Mencegah peralatan cepat rusak.
- c. Mencegah terjadinya infeksi silang.

Prosedur Kerja

Pemeliharaan Peralatan dari Logam

- a. Membersihkan dan desinfektan :

- 1) Peralatan :
 - a) Alat kotor
 - b) Larutan desinfektan, gelas pengukur
 - c) Bak/ember tempat merendam
 - d) Air mengalir
- 2) Prosedur :
 - a) Memakai sarung tangan
 - b) Membersihkan alat dari kotoran yang melekat dibawah air kran mengalir
 - c) Dikeringkan (setelah kering dimasukan kesterilisator)

- b. Menyeterilkan dan Penyimpanan Alat Logam

- 1) Peralatan :
 - a) Alat-alat logam
 - b) Sterilisator
 - c) Panas kering
 - d) Kain pembungkus bila perlu
- 2) Prosedur :
 - a) Memakai panas kering (sterilisator)
 - b) Menyusun alat-alat ke dalam bak instrumen dalam keadaan bersih/kering
 - c) Membungkus bak instrumen berisi alat dengan kain
 - d) Memasukkan alat ke dalam autoclave (sentral) selama 30 menit untuk yang dibungkus, 20 menit untuk yang tidak dibungkus.
 - e) Mengangkat alat dari sterilisator dan menyimpan dalam tempatnya

Pemeliharaan Tensi Meter

- a. Mengunci air raksa setelah pemakaian alat.
- b. Menggulung kain beserta manset dan disusun/dimasukkan ke dalam bak tensimeter.
- c. Menutup tensimeter dan menyimpan pada tempatnya.
- d. Kain manset dicuci bila kotor atau satu kali seminggu.
- e. Perhatikan kaca pengukur harus tetap dalam keadaan bersih dan mudah di baca.

Membersihkan Dan Mendesinfeksi Serta Menyimpan Pispot

- a. Peralatan
 - 1) Pispot + urinal kotor.
 - 2) Sarung tangan
 - 3) Larutan desinfektan (bayclin)
 - 4) Bak septik tank
 - 5) Keranjang sampah.
 - 6) Bak/ ember tempat merendam.
 - 7) Lap bersih dan kering.
 - 8) Sikat bertangkai
- b. Prosedur
 - 1) Membawa pispot yang kotor ke dalam spoel hoek.
 - 2) Memakai sarung tangan.
 - 3) Membuang tissue bekas pakai keranjang ke keranjang sampah, dengan memakai korentang spoel hoek
 - 4) Membuang kotoran ke bak septik tank, kemudian mengalirkan air kran supaya kotoran masuk tangki septik tank. Membilas alat dari kotoran yang masuk, melekat dengan mempergunakan sikat bertangkai
 - 5) larutan desinfektan sampai semua permukaan pispot terendam.
 - 6) Membersihkan pispot dengan cara menyikat memakai air sabun/ detergen.
 - 7) Membilas pispot di bawah air mengalir
 - 8) Merendam pispot di bak /ember tempat perendam yang berisi (bayclin)
 - 9) Mengeringkan pot dengan kain lap.
 - 10) Menyimpan pot pada tempatnya.

Membersihkan Dan Mendesinfeksi Serta Menyimpan Urinal

- a. Peralatan
 - 1) Urinal yang kotor.
 - 2) Sarung tangan
 - 3) Larutan desinfektan
 - 4) Bak septik tank.
 - 5) Bak/ ember perendam
 - 6) Lab bersih dan kering
 - 7) Sikat
- b. Prosedur
 - 1) Membawa urinal ke kamar spoel hoek.
 - 2) Memakai sarung tangan.

- 3) Membuang urinal ke bak septik tank.
- 4) Membilas urinal dengan air.
- 5) Merendam urinal dalam bak/ ember yang berisi larutan desinfektan sampai semua permukaan urinal terendam (konsentrasi sama dengan perendaman pispot)
- 6) Memberihkan dengan cara menyikat memakai sabun/detergen
- 7) Membilas urinal dibawah air mengalir
- 8) Mengeringkan urinal dan menggantungkannya ditempatnya

1.5. Prosedur Tindakan Perawatan Alat Kesehatan

NO	PROSEDUR TINDAKAN
	Mencuci Alat
1	Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan
2	Membersihkan alat yang kotor dengan sabun di air mengalir
3	Mengeringkan alat yang sudah dibersihkan
	Mensterilkan Alat
4	Menyiapkan alat yang sudah dibersihkan dan keringkan
5	Memilah alat (membungkus bila perlu dibungkus)
6	Memasukan dan menata alat ke dalam mesin sterilisator
7	Menyetel/menyalakan mesin sterilisator
8	Setelah steril, menyimpan alat pada tempatnya
TOTAL	

BAB 2

PENYIAPAN TEMPAT TIDUR PASIEN

2.1. Menyiapkan Tempat Tidur

Tempat tidur adalah sebuah perabot atau perlengkapan yang digunakan untuk tidur atau beristirahat. Dalam konteks kesehatan, khususnya di rumah sakit atau fasilitas medis, tempat tidur pasien dirancang secara khusus untuk memberikan kenyamanan dan mendukung kebutuhan medis pasien, seperti mengatur posisi tubuh, menyesuaikan ketinggian, dan memudahkan akses bagi perawatan medis.

Merapikan tempat tidur adalah kegiatan menata ulang tempat tidur agar rapi, bersih, dan nyaman digunakan kembali. Dalam lingkungan perawatan kesehatan, seperti rumah sakit atau puskesmas, merapikan tempat tidur pasien meliputi mengganti sprei atau seprai, meluruskan selimut, merapikan bantal, serta memastikan tidak ada kerutan atau lipatan yang bisa menyebabkan ketidaknyamanan atau luka tekanan pada pasien.

2.2. Syarat-Syarat Tempat Tidur Dalam Perawatan Kesehatan

1. Kebersihan dan mudah dibersihkan

- Tempat tidur harus mudah untuk dibersihkan dan disterilkan. Mengingat pentingnya menjaga kebersihan di area perawatan, material tempat tidur sebaiknya terbuat dari bahan yang mudah dicuci, tahan terhadap cairan, dan tidak menyerap kotoran atau debu.
- Kebersihan fasilitas kesehatan, termasuk tempat tidur, adalah faktor utama dalam mencegah infeksi silang di rumah sakit.

2. Kenyamanan Pasien

- Tempat tidur harus memberikan kenyamanan maksimal bagi pasien untuk mendukung istirahat dan pemulihan mereka. Kasur yang terlalu keras atau terlalu lembut bisa menyebabkan ketidaknyamanan dan memperburuk kondisi pasien.
- Tempat tidur yang nyaman membantu meningkatkan kualitas tidur dan kesejahteraan pasien, yang berdampak positif pada proses pemulihan.

3. Keamanan Pasien

- Tempat tidur harus dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan seperti rel pengaman di sisi kanan dan kiri untuk mencegah pasien jatuh, terutama bagi pasien dengan keterbatasan mobilitas.
- Penggunaan rel pengaman pada tempat tidur rumah sakit untuk mencegah cedera akibat jatuh.

4. Dapat Disesuaikan (Adjustable)

- Untuk kenyamanan dan kemudahan perawatan, tempat tidur sebaiknya memiliki fitur penyesuaian, baik secara manual maupun elektrik. Kemampuan untuk mengatur posisi punggung, bagian kaki, atau ketinggian tempat tidur sangat penting bagi pasien yang memerlukan perawatan khusus.
- Tempat tidur dengan fitur adjustable memungkinkan perawatan lebih mudah dan mengurangi beban kerja perawat, khususnya dalam posisi pasien yang membutuhkan penanganan intensif.

5. Kapasitas dan Kualitas Material

- Tempat tidur harus mampu menahan berat pasien dengan kapasitas yang cukup kuat. Material tempat tidur juga harus tahan lama dan mampu menahan beban berat serta penggunaan yang sering tanpa cepat rusak.

- Material yang digunakan untuk peralatan medis, termasuk tempat tidur, harus kuat, tahan lama, dan tidak mudah mengalami kerusakan akibat seringnya penggunaan.
6. **Mobilitas (Roda)**
 - Tempat tidur di fasilitas kesehatan sebaiknya dilengkapi dengan roda yang dapat digerakkan untuk memudahkan pemindahan pasien ketika diperlukan, misalnya dalam situasi darurat atau pemindahan ke ruang lain.
 - Mobilitas tempat tidur membantu dalam penanganan pasien, terutama ketika pasien perlu dipindahkan atau diposisikan ulang dalam ruangan.
 7. **Ventilasi dan Pencegahan Luka Tekan**
 - Tempat tidur yang baik harus dapat menjaga sirkulasi udara pada kasur untuk mencegah terjadinya luka tekan pada pasien yang harus berbaring lama. Kasur dengan permukaan yang membantu sirkulasi udara sangat dianjurkan.
 - Tempat tidur dengan sistem ventilasi membantu mencegah luka tekan, yang sangat penting untuk pasien dengan mobilitas terbatas.
 8. **Desain Ergonomis untuk Perawat**
 - Tempat tidur yang ergonomis tidak hanya memberikan kenyamanan bagi pasien tetapi juga memudahkan perawat dalam melakukan prosedur perawatan.
 - Pentingnya desain tempat tidur yang ergonomis dalam meningkatkan efisiensi perawatan dan mengurangi risiko cedera pada tenaga kesehatan.

2.3. Jenis-Jenis Tempat Tidur.

Jenis-Jenis Tempat Tidur dalam Perawatan Kesehatan :

1. **Tempat Tidur Standar (Standard Bed).**
 - Deskripsi: Tempat tidur ini memiliki desain sederhana, seringkali tanpa fitur penyesuaian. Biasanya digunakan di ruang perawatan umum yang tidak membutuhkan pengaturan khusus.
 - Kelebihan: Ekonomis dan mudah digunakan, cocok untuk pasien yang tidak memerlukan perawatan khusus.
 - Kekurangan: Kurang fleksibel dalam pengaturan posisi, sehingga tidak cocok untuk pasien dengan keterbatasan mobilitas.
2. **Tempat Tidur Manual (Manual Hospital Bed)**
 - Deskripsi: Tempat tidur ini dapat diatur secara manual dengan bantuan engkol atau tuas di bagian samping tempat tidur. Biasanya terdapat tiga pengaturan utama: ketinggian tempat tidur, bagian punggung, dan bagian kaki.
 - Kelebihan: Tidak memerlukan listrik, sehingga lebih hemat biaya dan cocok untuk klinik atau rumah sakit dengan akses listrik terbatas.
 - Kekurangan: Pengaturannya membutuhkan tenaga dan tidak sepraktis tempat tidur elektrik.
3. **Tempat Tidur Elektrik (Electric Hospital Bed)**
 - Deskripsi: Tempat tidur ini dapat diatur menggunakan tombol elektronik yang dapat mengubah posisi punggung, kaki, dan ketinggian tempat tidur secara otomatis.
 - Kelebihan: Memberikan kenyamanan dan kemudahan, baik bagi pasien maupun tenaga medis, karena pengaturan posisi bisa dilakukan tanpa tenaga fisik.
 - Kekurangan: Memerlukan sumber listrik, dan umumnya memiliki harga lebih tinggi dibandingkan tempat tidur manual.

4. Tempat Tidur ICU (Intensive Care Unit Bed)
 - Deskripsi: Tempat tidur ini dirancang khusus untuk perawatan intensif, dengan fitur-fitur canggih seperti pemantauan tekanan, penyesuaian posisi otomatis, serta sering dilengkapi sistem keamanan tambahan.
 - Kelebihan: Ideal untuk pasien dengan kondisi kritis yang membutuhkan penanganan cepat, karena mudah diatur dan dilengkapi berbagai sensor.
 - Kekurangan: Biaya yang sangat tinggi dan membutuhkan perawatan khusus.
5. Tempat Tidur Low Bed (Tempat Tidur Rendah)
 - Deskripsi: Tempat tidur ini dirancang dengan ketinggian rendah untuk meminimalkan risiko cedera akibat jatuh, terutama pada pasien lansia atau pasien dengan gangguan mobilitas.
 - Kelebihan: Mengurangi risiko cedera pada pasien yang cenderung bergerak atau berisiko jatuh.
 - Kekurangan: Tidak cocok untuk pasien yang memerlukan penyesuaian posisi tinggi atau pengaturan intensif.
6. Tempat Tidur Air Flow (Air Fluidized Bed)
 - Deskripsi: Tempat tidur ini menggunakan aliran udara untuk mengurangi tekanan di titik-titik tertentu, yang sangat bermanfaat bagi pasien dengan luka tekanan atau luka bakar.
 - Kelebihan: Sangat efektif dalam mengurangi risiko luka tekanan dan mempercepat penyembuhan luka.
 - Kekurangan: Memiliki harga yang tinggi dan membutuhkan perawatan khusus.
7. Tempat Tidur Pediatric (Tempat Tidur Anak)
 - Deskripsi: Dirancang khusus untuk anak-anak, tempat tidur ini biasanya lebih kecil dan memiliki fitur pengaman tambahan seperti pagar atau rel yang lebih tinggi untuk mencegah jatuh.
 - Kelebihan: Dirancang untuk kenyamanan dan keamanan anak-anak selama perawatan.
 - Kekurangan: Ukurannya terbatas hanya untuk anak-anak.

2.4. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Perawatan Tempat Tidur

1. Hindari kontaminasi pada linen bersih.
2. Ketika akan mengganti linen pada tempat tidur klien, bawa linen sesuai kebutuhan. Jangan membawa linen berlebihan untuk menghindari terjadinya kontaminasi kuman atau mikroorganisme dan infeksi nosokomial dari satu klien ke Klien lain.
3. Pada saat memasang linen bersih, Bentangkan Line di atas tempat tidur, jangan dikibaskan.
4. Jangan menempatkan linen kotor pada tempat tidur klien, meja atau peralatan klient lainnya.
5. Jangan memasang linen atau alat tenun pada tempat tidur klien, Gunakan cara yang efektif dan kerjakan pada satu sisi dulu, setelah selesai, baru pindah ke sisi lain.
6. Tempatkan linen atau alat tenun yang kotor pada tempat yang tertutup (ember yang ada tutupnya). Bawa dengan hati-hati jangan menyentuh pakaian perawat dan cuci tangan setelahnya.
7. Perawat harus tetap memperhatikan keadaan umum klien selama melaksanakan tindakan.

2.5. Mengganti Linen Dengan Pasien Diatas Tempat Tidur

Persiapan Alat :

1. Bed standar
2. Trolley
3. Baki dan pengalas
4. Sprei
5. Stik laken
6. Perlak (Zeil)
7. Sarung bantal
8. Selimut
9. Tempat linen kotor tertutup
10. Larutan desinfektan dalam botol semprot
11. Air bersih dalam botol semprot
12. Lap kerja 3 buah
13. Hand scoon bersih
14. Celemek

Prosedure kerja :

Tahap Pra Interaksi
1. Pelajari data tentang klien/pasien sebagai persiapan melakukan pekerjaan
2. Siapkan alat sesuai dengan intruksi kerja 1
3. Dekatkan alat ke dekat pasien
4. Lakukan cuci tangan sebelum melakukan tindakan
Tahap Orientasi
5. Sampaikan salam terapeutik pada klien/pasien
6. Jelaskan intruksi kerja 1 yang akan dilakukan
7. Tanyakan kesiapan pasien dalam tindakan intruksi kerja 1
Tahap Kerja
Mengganti Linen Dengan Pasien Di Atas Tempat Tidur
8. Menjaga privacy pasien
9. Memakai APD
10. Posisikan pasien pada tempat yang memungkinkan untuk mengganti alat tenun kemudian miringkan pasien ke arah berlawanan dengan perawat dan pasang pengaman tempat tidur
11. Menempatkan bantal dibawah kepala pasien
12. Melepaskan alat tenun dari bawah dimana perawat berdiri
13. Menggulung alat tenun sampai ke punggung pasien
14. Membersihkan tempat tidur dan rangka sebelah tempat perawat berdiri dengan menggunakan larutan desinfektan, lalu dibersihkan dengan air bersih dan dikeringkan.
15. Membentangkan spreï bersih memanjang dengan lipatan tengahnya tepat pada bagian tengah tempat tidur
16. Menyisipkan spreï bagian kepala dan kaki ke bawah kasur
17. Membentangkan perlak dan stik laken
18. Menyisipkan spreï dan perlak beserta stik laken ke bawah kasur dari arah kepala ke

kaki pasien dengan membentuk sudut
19. Menelentangkan pasien
20. Memiringkan pasien ke arah sisi perawat, bila pasien tidak mampu maka dibantu perawat lain yang memegang atau menahan bagian bahu dan paha pasien dari sisi lain dan memasang pengaman tempat tidur (bila ada)
21. Perawat pindah ke sisi lain dengan membawa alat kebersihan
22. Mengangkat spre, perlak dan stik laken yang kotor dengan bagian kotor berada di dalam dan memasukan ketempat laken kotor
23. Membersihkan tempat tidur seperti yang dilakukan pada sisi sebelumnya
24. Menarik spre bersih, perlak dan stik laken pada punggung pasien lalu bentangkan sampai rata
25. Menyisipkan spre, perlak dan stik laken dari bagian kepala ke kaki kebawah kasur kemudian membuat sudut
26. Menelentangkan pasien
27. Mengangkat bantal, diratakan isinya dan diganti sarungnya dengan yang bersih, lalu diletakan kembali dibawah kepala pasien
28. Mengganti selimut yang kotor dengan yang bersih kemudian menyisipkan selimut bagian kaki ke bawah kasur
Tahap Terminasi
29. Merapikan pasien dan membereskan peralatan
30. Evaluasi tindakan kepada pasien dan berpamitan dengan pasien
31. Melepaskan APD
32. Mencuci tangan
33. Mencatat kegiatan dalam lembar catatan keperawatan

BAB 3

PERTOLONGAN PENGUBAHAN POSISI KLIEN

3.1. Pengertian

Memposisikan klien adalah memberikan/mengubah posisi klien sesuai dengan posisi yang diinginkan/protap yang ada.

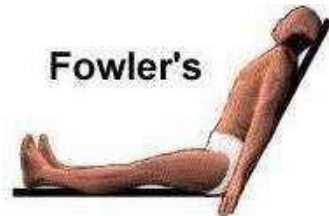
Tujuan :

1. Memberi kenyamanan pada klien
2. Prosedural tindakan
3. Terapi/pengobatan

3.2. Macam-Macam Posisi :

1. Posisi Fowler

Posisi fowler adalah posisi setengah duduk atau duduk, dimana bagian kepala tempat tidur lebih tinggi atau dinaikkan. Posisi ini dilakukan untuk mempertahankan kenyamanan dan memfasilitasi fungsi pernapasan klien. Posisi fowler merupakan posisi bed dimana kepala dan dada dinaikkan setinggi 45-90 tanpa fleksi lutut.



Tujuan

1. Mengurangi komplikasi akibat immobilisasi.
2. Meningkatkan rasa nyaman
3. Meningkatkan dorongan pada diafragma sehingga meningkatnya ekspansi dada dan ventilasi paru
4. Mengurangi kemungkinan tekanan pada tubuh akibat posisi yang menetap

Indikasi

1. Pada klien yang mengalami gangguan pernapasan
2. Pada klien yang mengalami imobilisasi

Alat dan bahan :

1. Tempat tidur khusus
2. Selimut
3. Bantal kecil
4. Gulungan handuk
5. Bantalan kaki
6. Sarung tangan (bila diperlukan)

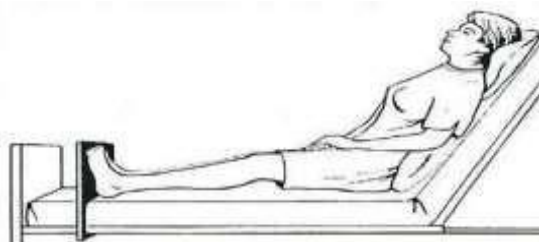
Cara kerja :

1. Jelaskan prosedur yang akan dilakukan.
2. Cuci tangan dengan menggunakan sarung tangan bila diperlukan. Menurunkan transmisi mikroorganisme.
3. Minta klien untuk memfleksikan lutut sebelum kepala dinaikkan. Mencegah klien melorot kebawah pada saat kepala dinaikkan.
4. Naikkan kepala bed 45° sampai 90° sesuai kebutuhan. (semi fowler fowler 15-45 tinggi 90)

5. Letakkan bantal kecil dibawah punggung pada kurva lumbal jika ada celah disana. Bantal akan mencegah kurva lumbal dan mencegah terjadinya fleksi lumbal.
6. Letakkan bantal kecil dibawah kepala klien. Bantal akan menyangnya kurva cervikal dari columna vertebra. Sebagai alternatif kepala klien dapat diletakkan diatas kasur tanpa bantal. Terlalu banyak bantal dibawah kepala akan menyebabkan fleksi kontraktur dari leher.
7. Letakkan bantal dibawah kaki, mulai dari lutut sampai tumit. Memberikan landasan yang, lembut dan fleksibel, mencegah ketidaknyamanan akibat dari adanya hiperekstensi lutut, membantu klien supaya tidak melorot ke bawah.
8. Pastikan tidak ada pada area popliteal dan lutut dalam keadaan fleksi. Mencegah terjadinya kerusakan pada persyarafan dan dinding vena. Fleksi lutut membantu supaya klien tidak melorot kebawah.
9. Letakkan bantal atau gulungan handuk dibawah paha klien. Bila ekstremitas bawah klien mengalami paralisa atau tidak mampu mengontrol ekstremitas bawah, gunakan gulungan trokhanter selain tambahan bantal dibawah panggulnya. Mencegah hiperekstensi dari lutut dan oklusi arteri popliteal yang disebabkan oleh tekanan dari berat badan. Gulungan trokhanter mencegah eksternal rotasi dari pinggul.
10. Topang telapak kaki dengan menggunakan footboart. Mencegah plantar fleksi.
11. Letakkan bantal untuk menopang kedua lengan dan tangan, bila klien memiliki kelemahan pada kedua lengan tersebut. Mencegah dislokasi bahu kebawah karena tarikan gravitasi dari lengan yang tidak disangga, meningkatkan sirkulasi dengan mencegah pengumpulan darah dalam vena, menurunkan edema pada lengan dan tangan, mencegah kontraktur fleksi pergelangan tangan.
12. Lepaskan sarung tangan dan cuci tangan
13. Dokumentasikan tindakan yang telah dilakukan

2. Posisi Semi Fowler

Semi fowler adalah sikap dalam posisi setengah duduk 15-45 derajat



Tujuan

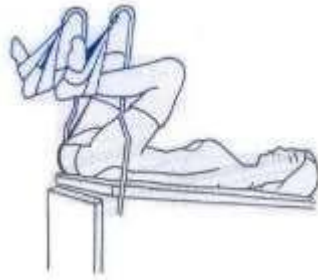
1. Mobilisasi
2. Memberikan perasaan lega pada klien sesak nafas
3. Memudahkan perawatan misalnya memberikan makan

Cara/prosedur

Sama seperti posisi fowler, hanya berbeda pada sudut pengangkatanya saja yaitu 15-45⁰

3. Posisi Lithotomi

Posisi berbaring telentang dengan mengangkat kedua kaki dan menariknya ke atas bagian perut. Posisi ini dilakukan untuk memeriksa genitalia pada proses persalinan, dan memasang alat kontrasepsi.



Indikasi

1. Untuk ibu hamil
2. Untuk persalinan
3. Untuk wanita yang ingin memasang alat kontrasepsi

Alat dan Bahan

1. Tempat tidur khusus
2. Selimut

Cara Kerja

1. Klien dalam keadaan berbaring telentang, kemudian angkat kedua paha dan tarik ke arah perut
2. Tungkai bawah membentuk sudut 90 derajat terhadap paha
3. Letakkan bagian lutut/kaki pada tempat tidur khusus untuk posisi lithotomic
4. Pasang selimut

4. Posisi Dorsal Recumbent

Pada posisi ini klien berbaring terlentang dengan kedua lutut flexi (ditarik atau diregangkan) diatas tempat tidur. Posisi ini dilakukan untuk merawat dan memeriksa genitalia serta pada proses persalinan.

POSISI DORSAL RECUMBENT



Tujuan

Meningkatkan kenyamanan klien, terutama dengan ketegangan punggung belakang.

Indikasi

- Klien yang akan melakukan perawatan dan pemeriksaan genitalia
- Untuk persalinan

Alat dan Bahan

1. Tempat tidur
2. Selimut

Cara Kerja

1. Jelaskan prosedur yang akan dilakukan
 2. Klien dalam keadaan berbaring telentang
 3. Pakaian bawah di buka
 4. Tekuk lutut dan di renggangkan
 5. Pastikan kedua telapak kaki menapak ditempat tidur
 6. Pasang selimut untuk menutupi area genitalia
5. Posisi Sim (Miring Kanan/Kiri)
- Posisi sim adalah posisi miring ke kanan atau ke kiri, posisi ini dilakukan untuk memberi kenyamanan dan memberikan obat melalui anus (supositoria).



Tujuan

- Mengurangi penekanan pada tulang sacrum dan trochanter mayor otot pinggang
- Meningkatkan drainage dari mulut klien dan mencegah aspirasi
- Memasukkan obat supositoria
- Mencegah dekubitus

Indikasi

1. Untuk klien yang akan di huknah
2. Untuk klien yang akan diberikan obat melalui anus

Alat dan Bahan

1. Tempat tidur khusus
2. Selimut

Prosedur Kerja

1. Jelaskan prosedur yang akan dilakukan
2. Geser pasien ke samping tempat tidur berlawanan dengan arah posisi sim yang akan dituju
3. Berdiri di samping pasien pada posisi yang akan dituju
4. letakkan lengan pasien yang dekat dengan perawat sejajar dengan punggung pasien dan tangan satunya ditekuk di depa dada
5. Tekuk lutut yang jauh dari perawat dan tarik ke arah perut
6. Pegang bahu pasien dengan tangan kiri dan pinggang dengan tangan kanan
7. Mendorong bahu dan pinggang pasien sehingga berada pada posisi setengah telungkup
8. Geser lengan yang berada dibawah tubuh pasien ke belakang dan letakkan tangan yang satunya di bawah pipi pasien
9. Bila klien miring ke kanan dengan posisi badan setengah telungkup dan kaki kanan lurus, lutut dan paha kiri ditekuk diarahkan ke dada.
10. Letakkan bantal atau guling diantara kedua lutut.

6. Posisi Trendelenberg

Pada posisi ini klien berbaring di tempat tidur dengan bagian kepala lebih rendah daripada bagian kaki. Posisi ini dilakukan untuk melancarkan peredaran darah ke otak.



Indikasi

- Klien dengan pembedahan pada daerah perut
- Klien shock
- Klien hipotensi.

Alat dan Bahan

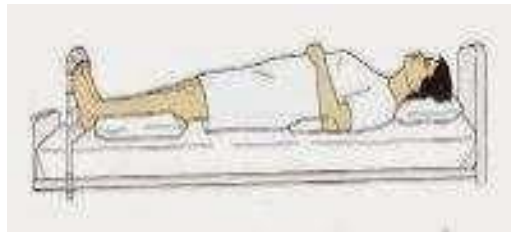
1. Tempat tidur khusus
2. Selimut

Cara Kerja

1. Menjelaskan prosedur yang akan dilakukan
2. Posisikan klien berbaring telentang, kemudian angkat bantal dibawah kepala
3. Memasang balok pada kedua kaki tempat tidur, di bagian kaki klien atau menaikkan pada bagian kaki bila ada tempat tidur yang biasa diatur.
4. Merapikan klien
5. Perhatikan keadaan umum klien selama bekerja

7. Posisi Supinasi

Posisi terlentang adalah posisi dimana klien berbaring terlentang dengan kepala dan bahu sedikit elevasi menggunakan bantal. Posisi terlentang dengan klien menyandarkan punggungnya agar dasar tubuh sama dengan kesejajaran berdiri yang baik.



Tujuan

Meningkatkan kenyamanan klien dan memfasilitasi penyembuhan terutama pada klien pembedahan atau dalam proses anestesi tertentu, untuk mengatasi masalah yang timbul akibat pemberian posisi pronasi yang tidak tepat.

Indikasi

- Klien dengan tindakan post anestesi atau penbedahan tertentu
- Klien dengan kondisi sangat lemah atau koma.

Alat dan Bahan

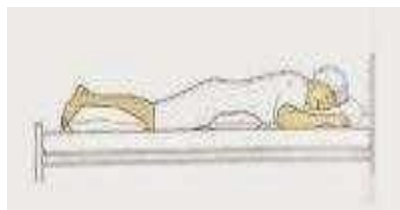
1. Tempat tidur
2. Bantal angin
3. Gulungan handuk
4. Footboard
5. Sarung tangan (bila diperlukan)

Prosedur Kerja

1. Cuci tangan dengan menggunakan sarung tangan bila diperlukan. Menurunkan transmisi mikroorganisme.
2. Baringkan klien terlentang mendatar ditengah tempat tidur. Menyiapkan klien untuk posisi yang tepat.
3. Letakkan bantal dibawah kepala, leher dan bahu klien. Mempertahankan body alignment yang benar dan mencegah kontraktur fleksi pada vertebra cervical.
4. Letakkan bantal kecil dibawah punggung pada kurva lumbal, jika ada celah disana. Bantal akan menyangga kurva lumbal dan mencegah terjadinya fleksi lumbal.
5. Letakkan bantal dibawah kaki mulai dari lutut sampai tumit. Memberikan landasan yang lebar, lembut dan fleksibel, mencegah ketidaknyamanan dari adanya hiperektensi lutut dan tekanan pada tumit.
6. Topang telapak kaki klien dengan menggunakan footboard. Mempertahankan telapak kaki dorsofleksi, mengurangi resiko foot-droop.
7. Jika klien tidak sadar atau mengalami paralise pada ekstremitas atas, maka elevasikan tangan dan lengan bawah (bukan lengan atas) dengan menggunakan bantal. Posisi ini mencegah terjadinya edema dan memberikan kenyamanan. Bantal tidak diberikan pada lengan atas karena dapat menyebabkan fleksi bahu.
8. Lepaskan sarung tangan dan cuci tangan
9. Dokumentasikan tindakan yang telah dilakukan

8. Posisi Pronasi

Posisi pronasi (posisi telungkup) adalah posisi dimana klien berbaring diatas abdomen dengan kepala menoleh kesamping.



Tujuan

- Memberikan ekstensi maksimal pada sendi lutut dan pinggang
- Mencegah fleksi dan kontraktur pada pinggang dan lutut.
- Memberikan drainase pada mulut sehingga berguna bagi klien post operasi mulut atau tenggorokan.

Indikasi

1. Klien yang menjalani bedah mulut dan kerongkongan
2. Klien dengan pemeriksaan pada daerah bokong atau punggung.

Alat dan Bahan

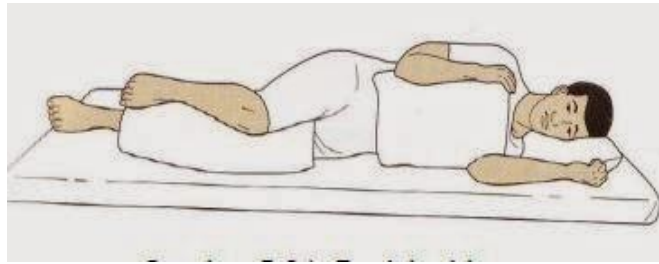
1. Tempat tidur
2. Bantal angin
3. Gulungan handuk
4. Sarung tangan (bila diperlukan)

Prosedur Kerja

1. Cuci tangan dengan menggunakan sarung tangan bila diperlukan. Menurunkan transmisi mikroorganisme.
2. Baringkan klien terlentang mendatar di tempat tidur. Menyiapkan klien untuk posisi yang tepat.
3. Gulingkan klien dengan lengan diposisikan dekat dengan tubuhnya dengan siku lurus dan tangan diatas pahanya. Posisikan tengkurap ditengah tempat tidur yang datar. Memberikan posisi pada klien sehingga kelurusan tubuh dapat dipertahankan.
4. Putar kepala klien ke salah satu sisi dan sokong dengan bantal. Bila banyak drainase dari mulut, mungkin pemberian bantal dikontra indikasikan. Menurunkan fleksi atau hiperekstensi vertebra cervical.
5. Letakkan bantal kecil dibawah abdomen pada area antara diafragma (atau payudara pada wanita) dan illiac crest. Hal ini mengurangi tekanan pada payudara pada beberapa klien wanita, menurunkan hiperekstensi vertebra lumbal, dan memperbaiki pernafasan dengan menurunkan tekanan diafragma karena kasur.
6. Letakkan bantal dibawah kaki, mulai lutut sampai dengan tumit. Mengurangi plantar fleksi, memberikan fleksi lutut sehingga memberikan kenyamanan dan mencegah tekanan yang berlebihan pada patella.
7. Jika klien tidak sadar atau mengalami paralisa pada ekstremitas atas, maka elevasikan tangan dan lengan bawah (bukan lengan atas) dengan menggunakan bantal. Posisi ini akan mencegah terjadinya edema dan memberikan kenyamanan serta mencegah tekanan yang berlebihan pada patella.
8. Lepaskan sarung tangan dan cuci tangan
9. Dokumentasikan tindakan yang telah dilakukan

9. Posisi lateral

Posisi lateral adalah Posisi di mana klien berbaring di atas Salah satu sisi bagian tubuh dengan kepala menoleh ke samping.



Tujuan

1. memudahkan perawatan misalnya menggosok gigi
2. memudahkan melayani kebutuhan sendiri dll
3. mencegah terjadinya decubitus

Indikasi

Operasi yang melibatkan punggung dan panggul

Alat dan bahan

1. Bantal
2. Guling
3. Sarung tangan

Prosedure kerja

1. mencuci tangan
2. menutup pintu jendela tirai
3. Menggunakan sarung tangan
4. Menggeser pasien ke sisi tempat tidur yang berlawanan dengan posisi arah yang dituju
5. menggeser bantal ke arah posisi yang dituju
6. menjauhkan tangan pasien yang berada di dekat petugas dari Badan pasien
7. menyilangkan kaki pasien yang jauh dari petugas ke arah petugas
8. Memegang bahu dan pinggul pasien dan tarik ke arah petugas
9. Memberi guling di punggung pasien
10. meletakkan bantal di bawah lengan atas di depan dada pasien
11. memberi bantal di antara kedua paha
12. Lepaskan sarung tangan dan cuci tangan
13. Dokumentasikan tindakan yang telah dilakukan

10. Posisi Ortopnea

Posisi Ortopnea adalah adaptasi dari posisi folder tinggi, klien duduk di tempat tidur atau di tepi tempat tidur dengan meja yang menyilang di atas tempat tidur



Tujuan

- membantu mengatasi masalah kesulitan pernafasan dengan Berikan ekspansi dada maksimum
- membantu klien mengatasi masalah ekshalasi

Indikasi

Pasien dengan sesak berat dan tidk bisa tidur terlentang

Alat dan bahan

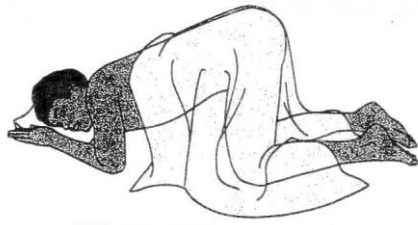
1. tempat tidur
2. bantal kecil
3. gulungan handuk
4. Bantalan
5. sarung tangan

Prosedur kerja

1. Cuci tangan
2. Tutup pintu jendela tirai
3. Gunakan sarung tangan
4. Minta klien untuk merefleksikan lutut sebelum kepala dinaikkan (mencegah klien melorot di bawah saat kepala di dinaikkan)
5. Naikkan kepala tempat tidur 90°
6. Letakkan bantal kecil di atas meja yang menyilang di atas tempat tidur
7. Letakkan bantal kaki di bawah kaki, mulai dari lutut sampai Sampai tumit (memberikan landasan yang lebar, lembut dan fleksibel, mencegah ketidaknyamanan akibat adanya hiperekstensi lutut dan tekanan pada tumit)
8. Pastikan tidak terdapat Tekanan pada area popliteal dan lutut dalam keadaan fleksi (mencegah terjadi kerusakan pada persyarafan dan dinding vena). Fleksi lutut membantu klien untuk tidak melorot ke bawah
9. Letakkan gulungan handuk di samping masing-masing paha (mencegah rotasi eksternal dari pinggul)
10. topang telapak kaki klient dengan menggunakan bantalan kaki
11. Lepaskan sarung tangan dan cuci tangan
12. Dokumentasikan tindakan yang telah dilakukan

10. Posisi Genu pectoral

Posisi genu pektoral adalah tindakan membaringkan pasien dengan posisi menungging, kedua kaki ditekuk dan dada menempel pada kasur



Tujuan

1. memudahkan tindakan pemeriksaan rektum dan sigmoid
2. membantu mengubah letak kepala janin pada pasien dengan kehamilan sungsang

Indikasi

1. pasien hemoroid
2. pemeriksaan dan pengobatan daerah rektum, sigmoid dan vagina

Alat dan bahan

1. tempat tidur yang sudah disiapkan dengan keadaan umum pasien
2. Bantal
3. sarung tangan

Prosedur kerja

1. Mencuci tangan
2. Menutup pintu, jendela, dan tirai
3. Gunakan sarung tangan
4. Menganjurkan untuk berlutut di atas tempat tidur
5. Meletakkan bantal di depan pasien
6. Menganjurkan pasien menoleh ke salah satu sisi dengan kedua tangan memegang bagian atas kepala
7. Menganjurkan pasien untuk merebahkan kepala dan dada di atas bantal dan tangan di atas kepala
8. Menganjurkan pasien untuk mempertahankan paha tegak lurus dengan tempat tidur
9. Melepaskan sarung tangan dan cuci tangan
10. Dokumentasikan tindakan yang telah dilakukan

3.3. Prosedur Tindakan Memposisikan Klien

FASE PRAINTERAKSI	
1	Mengidentifikasi kebutuhan/indikasi klien
2	Mencuci tangan
3	Menyiapkan alat
FASE ORIENTASI	
4	Mengucapkan salam & memperkenalkan diri
5	Menjelaskan tujuan prosedur tindakan
6	Menanyakan persetujuan klien untuk dilakukan tindakan
FASE KERJA	
7	Menjaga privasi (menutup sampiran)
8	Posisi Fowler dan Semi Fowler
9	Menggunakan sarung tangan bila diperlukan
10	Minta klien untuk memfleksikan lutut sebelum kepala dinaikkan

11	Naikkan kepala bed 45 sampai 90 sesuai kebutuhan (semi fowler 15-45 , fowler tinggi 90)
12	Letakkan bantal kecil dibawah punggung pada kurva lumbal jika ada celah Diana
13	Letakkan bantal kecil dibawah kepala klien. Sebagai alternatif kepala klien dapat diletakkan diatas kasur tanpa bantal
14	Letakkan bantal dibawah kaki, mulai dari lutut sampai tumit
15	Pastikan tidak ada pada area popliteal dan lutut dalam keadaan fleksi
16	Letakkan bantal atau gulungan handuk dibawah paha klien
17	Topang telapak kaki dengan menggunakan footboart
18	Letakkan bantal untuk menopang kedua lengan dan tangan, bila klien memiliki kelemahan pada kedua lengan tersebut
	Posisi Lithothi
19	Memposisikan klien dalam keadaan berbaring telentang,
20	Angkat kedua paha dan tarik ke arah perut
21	Tungkai bawah membentuk sudut 90 derajat terhadap paha
22	Letakkan bagian lutut/kaki pada tempat tidur khusus untuk posisi lithotomic
23	Pasang selimut
	Posisi Dorsal Recumbent
24	Klien dalam keadaan berbaring terlentang,
25	Pakaian bawah di buka
26	Tekuk lutut dan di renggangkan
27	Pastikan kedua telapak kaki menapak ditempat tidur
28	Pasang selimut untuk menutupi area genitalia
	Posisi Sim
29	Geser pasien ke samping tempat tidur berlawanan dengan arah posisi sim yang akan dituju
30	Berdiri di samping pasien pada posisi yang akan dituju
31	Letakkan lengan pasien yang dekat dengan perawat sejajar dengan punggung pasien dan tangan satunya ditekuk didepa dada
32	Tekuk lutut yang jauh dari perawat dan tarik kearah perut
33	Pegang bahu pasien dengan tangan kiri dan pinggang dengan tangan kanan
34	Mendorong bahu dan pinggang pasien sehingga berada pada posisi setengah telungkup
35	Geser lengan yang berada dibawah tubuh pasien ke belakang dan letakkan tangan yang satunya di bawah pipi pasien
36	Bila klien miring ke kanan dengan posisi badan setengan telungkup dan kaki kananlurus, lutut dan paha kiri ditekuk diarahakan ke dada.
37	Letakkan bantal atau guling diantara kedua lutut
	Posisi Trendelenberg
38	Posisikan klien berbaring telentang

39	Angkat bantalan yang menyangga kepala klien
40	Memasang balok pada kedua kaki tempat tidur, di bagian kaki klien atau menaikkan pada bagian kaki bila ada tempat tidur yang biasadiatur
	Posisi Supinasi
41	Baringkan klien terlentang mendatar ditengah tempat tidur
42	Letakkan bantal dibawah kepala, leher dan bahu klien
43	Letakkan bantal kecil dibawah punggung pada kurva lumbal, jika ada celah disana
44	Letakkan bantal dibawah kaki mulai dari lutut sampai tumit
45	Topang telapak kaki klien dengan menggunakan footboard
46	Jika klien tidak sadar atau mengalami paralise pada ekstremitas atas, maka elevasikan tangan dan lengan bawah (bukan lengan atas) dengan menggunakan bantal
	Posisi Pronasi
47	Baringkan klien terlentang mendatar di tempat tidur
48	Gulingkan klien dengan lengan diposisikan dekat dengan tubuhnya dengan siku lurus dan tangan diatas pahanya
49	Putar kepala klien ke salah satu sisi dan sokong dengan bantal
50	Letakkan bantal kecil dibawah abdomen pada area antara diafragma (atau payudara pada wanita) dan illiac crest.
51	Letakkan bantal dibawah kaki, mulai lutut sampai dengan tumit
52	Jika klien tidak sadar atau mengalami paralisa pada ekstremitas atas, maka elevasikan tangan dan lengan bawah (bukan lengan atas) dengan menggunakan bantal
	Posisi lateral
53	Menggeser pasien ke sisi tempat tidur yang berlawanan dengan posisi arah yang dituju
54	Menggeser bantal ke arah posisi yang dituju
55	Menjauhkan tangan pasien yang berada di dekat petugas dari Badan pasien
56	Menyilangkan kaki pasien yang jauh dari petugas ke arah petugas
57	Memegang bahu dan pinggul pasien dan tarik kearah petuga
58	Memberi guling di punggung pasien
59	Meletakkan bantal di bawah lengan atas di depan dada pasien
60	Memberi bantal di antara kedua paha
	Posisi Ortopnea
61	Minta klien untuk merefleksikan lutut sebelum kepala dinaikkan (mencegah klien melorot di bawah saat kepala di dinaikkan)
62	Naikkan kepala tempat tidur 90
63	Letakkan bantal kecil di atas meja yang menyilang di atas tempat tidur
64	Letakkan bantal kaki di bawah kaki, mulai dari lutut sampai Sampai tumit (memberikan landasan yang lebar, lembut dan fleksibel, mencegah ketidaknyamanan akibat adanya hiperekstensi lutut dan tekanan pada tumit)
65	Pastikan tidak terdapat Tekanan pada area popliteal dan lutut dalam keadaan fleksi (mencegah terjadi kerusakan pada persyarafan dan dinding vena). Fleksi lutut membantu klien untuk tidak melorot ke bawah
66	Letakkan gulungan handuk di samping masing-masing paha (mencegah rotasi

	eksternal dari pinggul)
67	topang telapak kaki klien dengan menggunakan bantalan kaki
	Posisi Genu Pectoral
68	Menganjurkan untuk berlutut di atas tempat tidur
69	Meletakkan bantal di depan pasien
70	Menganjurkan pasien menoleh ke salah satu sisi dengan kedua tangan memegang bagian atas kepala
71	Menganjurkan pasien untuk merebahkan kepala dan dada di atas bantal dan tangan di atas kepala
72	Menganjurkan pasien untuk mempertahankan paha tegak lurus dengan tempat tidur
FASE TERMINASI	
73	Merapikan klien dan alat
74	Mengevaluasi respon klien
75	Mengucapkan salam
76	Mencuci tangan
77	Mendokumentasikan prosedur dalam catatan klien

BAB 4

PERTOLONGAN AMBULASI PASIEN

4.1. Pengertian

Ambulasi dini merupakan suatu bentuk tahapan kegiatan yang dilakukan secara segera pada pasien pasca operasi. Ambulasi meliputi kegiatan yang dimulai dari bangun, sampai pasien turun dari tempat tidur dan mulai berjalan dengan menggunakan bantuan alat yang disesuaikan dengan kondisi pasien



4.2. Manfaat Ambulasi

Berikut adalah manfaat dari ambulasi

1. Guna mencegah imobilisasi yang terjadi pasca operasi yang meliputi sebagai berikut
 - a. Sistem pencernaan
Mencegah anoreksia-konstipasi, penurunan metabolisme
 - b. Sistem perkemihan
Mencegah perubahan pada eliminasi urine, infeksi saluran kemih, dan hiperkalsi uria
 - c. Sistem muskulo skeletal
Mencegah penurunan massa otot, osteoporosis, dan pemendekan serat otot
 - d. Sistem neurosensoris
Mencegah kerusakan jaringan, menimbulkan gangguan saraf pada bagian distal, dan nyeri yang hebat

- e. Sistem integumen
Mencegah kerusakan integritas kulit seperti abrasi, sirkulasi yang terlambat yang menyebabkan terjadinya atrofi akut dan perubahan turgor kulit
 - f. sistem kardiovaskuler
Mencegah penurunan cardiac reserve, peningkatan beban kerja jantung, hipotensi orthostatic, dan phlebothrombosis (flebotrombosis)
 - g. Respirasi
mencegah penurunan Kapasitas vital, penurunan ventilasi volentar maksimal, penurunan ventilasi atau perfusi setempat, mekanisme batuk yang menurun.
2. Guna memperbaiki sirkulasi, mencegah flebotrombosis (thrombosis vena profunda/DVT). Mengurangi komplikasi imobilisasi pascaoperasi, mempercepat pemulihan peristaltic usus, mempercepat pasien pascaoperasi

4.3. Alat Yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Ambulasi

berikut adalah alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaan ambulasi.

a. Canes

Canes (tongkat) adalah alat yang terbuat dari kayu atau logam setinggi pinggang yang digunakan pada pasien dengan lengan yang mampu dan sehat. Canes meliputi tongkat berkaki panjang lurus (single stight-legged) dan tongkat berkaki segi empat (quad cane).



b. Walker

Walker adalah alat yang terbuat dari logam mempunyai empat penyangga yang kokoh digunakan pada pasien yang mengalami kelemahan umum. alat lengan yang kuat dan mampu menopang tubuh.



c. Kruk

Kruk adalah alat yang terbuat dari logam atau kayu dan digunakan permanen untuk meningkatkan mobilisasi serta untuk menopang tubuh dalam keseimbangan pasien Adapun jenis-jenis kruk misalnya convensional adjustable dan lofstrand



4.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Ambulasi

1. kesehatan umum
penyakit, kelemahan, penurunan aktivitas, kurangnya latihan fisik, dan lelah kronik menimbulkan efek yang tidak nyaman pada fungsi musculoskeletal
2. tingkat kesadaran
Pasien dengan kondisi disorientasi, bingung atau mengalami perubahan tingkat kesadaran tidak mampu melakukan ambulasi dini pascaoperasi
3. Nutrisi
Pasien yang kurang nutrisi sering mengalami atrofi otot, penurunan jaringan subkutan yang serius, dan gangguan Keseimbangan cairan dan elektrolit. pasien juga akan mengalami defisiensi protein, keseimbangan nitrogen dan tidak adekuatnya asupan vitamin C.
4. Emosi
Perasaan nyaman, kebahagiaan, kepercayaan, dan penghargaan pada diri sendiri akan mempengaruhi pasien untuk melaksanakan prosedur ambulasi.
5. Tingkat pendidikan
Pendidikan menyebabkan perubahan pada kemampuan intelektual, mengarahkan pada keterampilan yang lebih baik dalam mengevaluasi informasi. pendidikan dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk mengatur kesehatan mereka, untuk mematuhi saran-saran kesehatan.
6. Pengetahuan
Hasil penelitian mengatakan bahwa perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan bertahan lama daripada yang tidak didasari oleh pengetahuan.

4.5. Prosedur Tindakan Ambulasi

FASE PRAINTERAKSI	
1	Mengidentifikasi kebutuhan/indikasi klien
2	Mencuci tangan
3	Menyiapkan alat
FASE ORIENTASI	
4	Mengucapkan salam & memperkenalkan diri
5	Menjelaskan tujuan prosedur tindakan
6	Menanyakan persetujuan klien untuk dilakukan tindakan
FASE KERJA	
7	Menjaga privasi (menutup sampiran)
8	Menggunakan APD
	Duduk Dan Tidur
9	Tempatkan pasien pada posisi terlentang
10	Pindahkan semua bantal

11	Posisi menghadap kepala tempat tidur
12	Regangkan kedua kaki perawat dengan kaki paling dekat ke kepala tempat tidur di belakang kaki yang lain
13	Tempatkan tangan yang lebih jauh dari pasien di bawah bahu pasien, lalu sokong kepalanya dan vertebra servikal
14	Tempatkan tangan perawat yang lain pada permukaan tempat tidur
15	Angkat pasien ke posisi duduk dengan memindahkan berat badan perawat dari depan kaki ke belakang kaki
16	Dorong melawan tempat tidur dengan tangan di permukaan tempat tidur
	Duduk di tepi tempat tidur
17	Tempatkan pasien pada posisi miring, menghadap perawat di sisi tempat tidur tempat ia akan duduk
18	Pasang pagar tempat tidur pada kedua sisi yang berlawanan
19	Tinggikan kepala tempat tidur pada ketinggian yang dapat ditoleransi
20	Berdiri pada sisi panggul pasien yang berlawanan
21	Balikan secara diagonal sehingga Anda berhadapan dengan pasien dan menjauh dari sudut tempat tidur
22	Regangkan kaki perawat dengan kaki paling dekat ke kepala tempat tidur di depan kaki yang lain
23	Tempatkan lengan yang lebih dekat ke kepala tempat tidur di bawah bahu pasien, sokong kepala dan lehernya
24	Tempatkan tangan perawat yang lain di atas paha pasien
25	Pindahkan tungkai bawah pasien dan kaki ke tepi tempat tidur
26	Tempatkan poros ke arah belakang kaki, yang memungkinkan tungkai atas pasien memutar ke bawah
27	Pada saat bersamaan, Pindahkan berat badan perawat ke belakang tungkai dan angkat pasien
28	Tetap di depan pasien sampai keseimbangan
29	Turunkan tinggi tempat tidur sampai kaki menyentuh lantai
	Membantu berjalan
30	Anjurkan pasien untuk meletakkan tangan di samping badan atau memegang telapak tangan perawat
31	Berdiri di samping pasien dan pegang telapak dan lengan bahu
32	Bantu pasien berjalan
	Memindahkan klien dari tempat tidur ke brankar atau sebaliknya
33	Klien diangkat sekurang-kurangnya 3 orang perawat (sesuai kebutuhan)
34	Ketiga perawat berdiri pada sisi kanan klien dengan urutan sbb: a. Perawat I (paling tinggi) berdiri di bagian kepala b. Perawat II berdiri di bagian pinggang Perawat III berdiri di bagian kaki
35	Lengan kiri perawat I dibawah kepala dan pangkal lengan klien di lengan kanan di bawah punggung klien (bila klien gemuk, lengan kanan perawat melalui badan klien ke bawah pinggang , sehingga berpegangan dengan tangan kiri perawat II)
36	Lengan kiri perawat II di bawah pinggang klien, lengan kanan dibawah bokong klien

37	Kedua lengan perawat III mengangkat seluruh tungkai klien
38	Setelah siap salah seorang perawat memberi aba-aba, kemudian bersama-sama mengangkat klien dari tempat tidur menuju brankard.
39	Setelah Klien berada diatas brankard, posisi diatur, perhatikan keadaan umum klien , selimut dipasang.
40	Begitu pula sebaliknya jika memindahkan klien dari brankard ke tempat tidur
Memindahkan klien dari tempat tidur ke kursi Roda	
41	Kursi roda didorong ke sisi tempat tidur dan roda dibelakangnya, kunci agar tidak terbalik
42	Berdiri menghadap klien dengan kedua kaki merenggang
43	Anjurkan klien untuk meletakkan kedua tangan di bahu anda
44	Kedua tangan perawat menopang bahu klien pada sisi yang lemah/sakit dan klien dianjurkan bertumpu pada sisi yang kuat
45	Perawat membantu klien untuk turun dari tempat tidur, berdiri tegak dan berjalan menuju kursi roda
46	Anjurkan klien untuk bersandar pada kursi roda dan letakkan kaki klien diatas sandaran kaki
47	Observasi keadaan umum klien
48	Begitu pula sebaliknya jika memindahkan klien dari korsi roda ketempat tidur
FASE TERMINASI	
49	Merapikan klien
50	Mengevaluasi respon klien
51	Mengucapkan salam
52	Mencuci tangan

BAB 5

PERTOLONGAN MOBILISASI PASIEN

5.1. Pengertian

Mobilisasi adalah suatu kemampuan seseorang untuk bergerak bebas, mudah, teratur, mempunyai tujuan memenuhi kebutuhan hidup aktivitasnya guna mempertahankan kesehatannya.

5.2. Tujuan Mobilisasi

1. Mempertahankan tingkat kesehatan
2. Mempertahankan interaksi sosial dan peran sehari-hari
3. Mencegah hilangnya kemampuan fungsi tubuh
4. Memenuhi kebutuhan dasar manusia
5. Mencegah terjadinya trauma

5.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mobilisasi

1. Gaya hidup
Gaya hidup seseorang sangat tergantung dari tingkat pendidikannya. Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan diikuti oleh perilaku yang dapat meningkatkan kesehatannya. Demikian halnya dengan pengetahuan kesehatan tentang mobilitas seseorang akan senantiasa melakukan mobilisasi dengan cara yang sehat., misalnya seorang ABRI akan berjalan dengan gaya berbeda dengan seorang pramugari atau seorang pemabuk.
2. Proses penyakit dan injury
Adanya penyakit tertentu seseorang akan mempengaruhi mobilitasnya. Misalnya, seseorang yang patah tulang akan kesulitan untuk mobilisasi secara bebas. Demikian pula orang yang baru menjalani operasi. Hal itu karena adanya nyeri mereka cenderung untuk bergerak lebih lambat. Ada kala klien harus istirahat di tempat tidur karena menderita penyakit tertentu Misalnya, CVA yang berakibat kelumpuhan, typhoid dan penyakit kardiovaskuler
3. Kebudayaan
kebudayaan dapat mempengaruhi pola dan sikap dalam melakukan aktivitas misalnya seorang anak desa yang biasa jalan kaki setiap hari akan berbeda mobilitasnya dengan anak kota yang biasa pakai mobil dalam segala keperluannya. Wanita Keraton akan berbeda mobilitasnya dibandingkan dengan wanita Madura dan sebagainya
4. Tingkat energi
setiap orang mobilisasi jelas memerlukan tenaga atau energi, orang yang lagi sakit akan berbeda mobilitasnya dibandingkan dengan orang yang sehat apalagi dengan seorang pelari
5. Usia dan status perkembangan
seorang anak akan berbeda tingkat kemampuan mobilitasnya dibandingkan dengan seorang remaja. Anak yang selalu sakit dalam masa pertumbuhannya akan berbeda pula tingkat kelincihannya dibandingkan dengan anak yang sehat
6. faktor resiko
berbagai faktor fisik, psikologis, dan lingkungan dapat menyebabkan imobilisasi pada usia lanjut

5.4. Jenis Mobilitas Dan Imobilitas

a. Jenis mobilitas

1. Mobilitas penuh

Mobilitas penuh merupakan kemampuan seseorang untuk bergerak secara penuh dan bebas sehingga dapat melakukan interaksi sosial dan menjalankan peran sehari-hari. mobilitas penuh ini merupakan fungsi saraf motorik volunteer dan sensorik untuk dapat mengontrol seluruh area tubuh pasien

2. Mobilitas sebagian

Mobilitas sebagian merupakan kemampuan seseorang untuk bergerak dengan batasan jelas dan tidak mampu bergerak secara bebas karena dipengaruhi oleh gangguan saraf motorik dan sensorik pada area tubuhnya. Hal ini dapat dijumpai pada kasus cedera atau patah tulang dengan pemasangan traksi. Pada pasien paraplegi dapat mengalami mobilitas sebagian pada ekstremitas bawah karena kehilangan kontrol motorik dan sensorik. Mobilitas sebagian ini dibagi menjadi dua jenis yaitu

a. Mobilitas sebagian emporer

Mobilitas sebagian emporer merupakan kemampuan individu untuk bergerak dengan batasan yang sifatnya sementara. Hal tersebut dapat disebabkan oleh trauma reversible pada sistem muskuloskeletal, contohnya adalah adanya dislokasi sendi dan tulang.

b. Mobilitas permanen

Mobilitas permanen merupakan kemampuan individu untuk bergerak dengan batasan yang sifatnya menetap. Hal tersebut disebabkan oleh rusaknya sistem saraf yang reversibel, contohnya terjadi hemiplegia karena stroke, paraplegi karena cedera tulang belakang, Poliomilitis karena terganggunya sistem saraf motorik dan sensorik

b. Jenis imobilitas

1. Imobilitas fisik

Imobilisasi fisik merupakan pembatasan untuk bergerak secara fisik dengan tujuan mencegah terjadinya gangguan komplikasi pergerakan.

2. Imobilisasi Intelektual

Imobilisasi intelektual merupakan keadaan ketika seseorang mengalami keterbatasan daya pikir

3. Imobilitas emosional

Imobilitas emosional merupakan keadaan ketika seseorang mengalami pembatasan secara emosional karena adanya perubahan secara tiba-tiba dalam menyesuaikan diri

4. Imobilitas sosial

imobilitas sosial merupakan keadaan individu yang mengalami hambatan dalam melakukan interaksi sosial karena keadaan penyakitnya, sehingga dapat mempengaruhi perannya dalam kehidupan sosial

5.5. Dampak Imobilitas

- a. Dampak fisiologis dari imobilitas antara lain dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Dampak Fisiologi Imobilitas

EFEK	HASIL
1. Penurunan fungsi ventrikel kiri	1. Intoleransi ortostatik
2. Penurunan volume sekuncup	2. peningkatan denyut jantung, sinkop
3. Perlambatan fungsi usus	3. Penurunan kapasitas kebugaran
4. Pengurangan miksi	4. Konstipasi
5. Gangguan tidur	5. penurunan evakuasi kandung kemih
6. Penurunan konsumsi oksigen maksimum	6. bermimpi pada siang hari, halusinasi

- b. Efek imobilisasi pada berbagai sistem organ bagi lihat pada tabel berikut

Efek Imobilisasi	
ORGAN ATAU SISTEM	PERUBAHAN YANG TERJADI AKIBAT IMOBILISASI
Muskuloskeletal	Osteoporosis, penurunan massa tulang, hilangnya kekuatan otot, penurunan area potong lintang otot, kontraktor, degenerasi rawan sendi, ankilosis, peningkatan tekanan intraartikular, berkurangnya volume sendi
kardiopulmonal dan pembuluh darah	peningkatan denyut nadi istirahat, penurunan perfusi miokard, intoleransi terhadap ortostatik, penurunan ambilan oksigen maksimal (VO ₂ Max), deconditioning jantung, penurunan volume plasma, perubahan uji fungsi paru, atelektasis paru, Pneumonia, peningkatan statis vena, peningkatan agresi trombosit, dan hiperkoagulasi
Integumen,	Peningkatan risiko ulkus dekubitus dan laserasi kulit
Metabolik dan endokrin	keseimbangan nitrogen negatif, hiperkalsiuria, natriuresis dan deplesi natrium, resistensi insulin (intoleransi glukosa), hiperlipidemia, serta penurunan absorpsi dan metabolisme vitamin atau mineral

5.6. Mobilisasi Dengan Memberikan Posisi Miring

1. indikasi

Berikut beberapa indikasi pasien yang membutuhkan mobilisasi posisi miring

- Penderita yang mengalami kelumpuhan baik hemiplegia maupun paraplegia
- Penderita yang mengalami kelemahan dan pasca
- Penderita yang mengalami pengobatan imobilisasi
- Penderita yang mengalami penurunan kesadaran

2. Alat-alat dan bahan

- Satu bantal penopang lengan
- Satu bantal penopang tungkai
- Satu bantal penopang tubuh bagian belakang

3. Prosedure Kerja

FASE PRAINTERAKSI	
1	Mengidentifikasi kebutuhan/indikasi klien
2	Mencuci tangan
3	Menyiapkan alat
FASE ORIENTASI	
4	Mengucapkan salam & memperkenalkan diri
5	Menjelaskan tujuan prosedur tindakan
6	Menanyakan persetujuan klien untuk dilakukan tindakan

FASE KERJA	
7	Pindahkan segala rintangan, sehingga anda dapat leluasa bergerak
8	Angkat atau singkirkan rail pembatas tempat tidur pada sisi di mana perawat akan melakukan mobilisasi
9	Pastikan posisi pasien pada bagian tengah tempat tidur posisi supinasi lebih mudah bila dilakukan mobilisasi lateral
10	Perawat mengambil posisi sebagai berikut a. Perawat mengambil posisi sedekat mungkin menghadap pasien di samping tempat tidur lurus pada bagian abdomen pasien sesuai arah posisi lateral. Misalnya, apabila akan memiringkan ke kanan, maka perawat ada di samping kanan pasien b. Kepala tegak dagu ditarik ke belakang untuk mempertahankan punggung pada Posisi tegak c. Posisi pinggang tegak untuk melindungi sendi dan ligamen d. Lebarkan jarak kedua kaki untuk menjaga kestabilan saat menarik tubuh pasien e. Lutut dan pinggul tertekuk atau fleksi
11	kemudian meletakkan tangan kanan lurus di samping tubuh pasien untuk mencegah pasien terguling saat ditarik ke posisi lateral (sebagai penyangga).
12	kemudian meletakkan tangan kiri pasien menyilang pada dadanya dan tungkai kiri menyilang di atas tungkai kanan dengan tujuan agar memberikan kekuatan saat didorong
13	Kemudian kencangkan otot gluteus dan abdomen serta kaki fleksi bersiap untuk melakukan tarikan terhadap tubuh pasien. Pastikan bahwa menggunakan otot terpanjang dan terkuat pada tungkai dengan tujuan mencegah trauma dan menjaga kestabilan
14	Letakkan tangan kanan perawat pada pangkal paha pasien dan tangan kiri diletakkan pada bahu pasien.
15	Kemudian tarik tubuh pasien ke arah perawat dengan cara sebagai berikut a. kuatkan otot tulang belakang dan geser berat badan perawat ke bagian pantat dan kaki b. Tambahkan fleksi kaki dan pelvis perawat lebih direndahkan lagi untuk menjaga keseimbangan pastikan bahwa posisi pasien tetap nyaman dan dan tetap dapat bernafas lega
16	kemudian atur posisi pasien dengan memberikan ganjaran bantal pada bagian yang penting sebagai berikut : a. Tubuh pasien berada di samping dan kedua lengan berada di bagian depan tubuh dengan posisi fleksi, berat badan pasien tertumpu pada bagian skapula dan ileum. Berikan bantal pada bagian kepala agar tidak terjadi abduksi dan adduksi pada sendi leher. b. Kemudian berikan bantal sebagai ganjalan antara kedua lengan dan dada untuk mencegah kelelahan otot dada dan terjadinya lateral fleksi serta untuk mencegah atau membatasi fungsi internal rotasi dan abduksi pada bahu dan lengan atas
17	Berikan ganjalan bantal bagian belakang tubuh pasien bila diperlukan untuk memberikan posisi yang tepat
FASE TERMINASI	
18	Merapikan klien, membereskan alat
19	Evaluasi tindakan kepada pasien dan berpamitan dengan pasien
20	Mencuci tangan
21	Dokumentasi tindakan yang telah dikerjakan

BAB 6

PERTOLONGAN PERSONAL HYGIENE

6.1. Pengertian Personal Hygiene

Personal hygiene adalah cara perawatan diri seseorang untuk memelihara kesehatannya. seseorang tidak dapat melakukan perawatan diri sendiri karena dipengaruhi kondisi fisik dan keadaan emosional pasien

6.2. Tujuan dari personal hygiene

1. Menghilangkan bau badan yang berlebihan
2. Menghilangkan minyak yang menumpuk, keringat, sel-sel kulit yang mati, dan bakteri
3. Memelihara integritas permukaan kulit
4. Menstimulasi sirkulasi peredaran darah
5. Meningkatkan derajat kesehatan
6. Memberikan kesempatan pada perawat untuk menggaji kondisi kulit pasien
7. Meningkatkan percaya diri seseorang
8. Pencegahan penyakit
9. Meningkatkan keindahan
10. Memperbaiki personal hygiene

6.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Personal Hygiene

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi personal hygiene yaitu sebagai berikut :

1. Pengetahuan
Tingkat pengetahuan seseorang tentang pentingnya personal hygiene memengaruhi perilaku kebersihannya. Orang dengan pemahaman yang baik akan lebih cenderung menjaga kebersihan pribadi.
2. Budaya dan Kebiasaan
Norma budaya dan tradisi mempengaruhi kebiasaan personal hygiene, seperti cara mencuci tangan, mandi, atau membersihkan mulut.
3. Sosial Ekonomi
Kondisi ekonomi memengaruhi kemampuan untuk membeli produk kebersihan seperti sabun, pasta gigi, atau pakaian bersih.
4. Lingkungan
Lingkungan fisik, seperti akses ke air bersih, sanitasi, dan fasilitas mandi, sangat mempengaruhi kebiasaan kebersihan.
5. Status Kesehatan
Orang dengan kondisi kesehatan tertentu, seperti gangguan fisik atau penyakit kronis, mungkin memiliki keterbatasan dalam menjaga kebersihan pribadi.
6. Psikologis dan Motivasi
Motivasi individu, kepercayaan diri, atau gangguan mental dapat memengaruhi perilaku personal hygiene.
7. Pendidikan dan Penyuluhan Kesehatan
Program pendidikan kesehatan dapat meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam menjaga kebersihan pribadi.
8. Pilihan Pribadi
Setiap pasien memiliki keinginan individu dan pilihan tentang kapan untuk mandi, bercukur, dan melakukan perawatan rambut.

9. Citra Tubuh

Penampilan umum pasien dapat menggambarkan pentingnya hygiene pada orang tersebut . Citra tubuh merupakan konsep subjektif seseorang tentang penampilan fisiknya. Citra tubuh ini dapat sering berubah. Citra tubuh mempengaruhi cara mempertahankan hygiene. jika seorang pasien rapi sekali maka perawat mempertimbangkan rincian kerapian ketika merencanakan keperawatan dan berkonsultasi pada pasien sebelum membuat keputusan tentang bagaimana memberikan perawatan yang hygiene. karena citra tubuh pasien dapat berubah akibat pembedahan atau penyakit fisik maka perawat harus membuat suatu usaha ekstra untuk meningkatkan hygiene

10. Praktek Sosial

Kelompok-kelompok sosial wadah seorang klien berhubungan dapat mempengaruhi praktek hygiene klien pribadi. selama masa kanak-kanak, kanak-kanak mendapat praktek hygiene dari orang tua mereka. kebiasaan keluarga, jumlah orang di rumah, dan ketersediaan air panas dan atau air mengalir hanya merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi perawatan kebersihan.

6.4. Pelaksanaan Personal Hygiene

Personal hygiene berdasarkan waktu pelaksanaannya dibagi menjadi 4 yaitu sebagai berikut :

a. Perawatan dini hari

Perawatan dini hari dilakukan pada waktu bangun tidur. Perawatan dini hari bertujuan untuk melakukan tindakan untuk tes yang terjadwal seperti dalam pengambilan bahan pemeriksaan(urine atau feses), memberikan pertolongan seperti menawarkan bedpan atau urinal jika pasien tidak mampu ambulasi, mempersiapkan pasien dalam melakukan sarapan atau makan pagi dengan melakukan tindakan personal hygiene, seperti mencuci muka, tangan dan menjaga kebersihan mulut

b. Perawatan pagi hari

Perawatan pagi hari adalah personal hygiene yang dilakukan setelah melakukan sarapan atau makan pagi seperti melakukan pertolongan dalam pemenuhan kebutuhan eliminasi (Bab / Bak), mandi atau mencuci rambut, melakukan perawatan kulit, melakukan pijatan pada punggung, membersihkan mulut, kuku, rambut, serta merapikan tempat tidur pasien. Hal ini sering disebut sebagai perawatan pagi yang lengkap

c. Perawatan siang hari

Perawatan siang hari adalah personal hygiene yang dilakukan setelah melakukan berbagai tindakan pengobatan atau pemeriksaan dan setelah makan siang di mana pasien yang dirawat di rumah sakit seringkali menjalani banyak tes diagnostik yang melelahkan di pagi hari. Berbagai tindakan personal hygiene yang dapat dilakukan, antara lain mencuci muka dan tangan, membersihkan mulut merapikan tempat tidur, dan melakukan pemeliharaan kebersihan lingkungan kesehatan pasien

d. Perawatan menjelang tidur

Perawatan menjelang tidur adalah personal hygiene yang dilakukan pada saat menjelang tidur agar pasien rileks, sehingga dapat tidur atau istirahat dengan tenang. berbagai kegiatan yang dapat dilakukan, antara lain pemenuhan kebutuhan eliminasi (Bab atau Bak), mencuci tangan dan muka membersihkan mulut, dan memijat daerah punggung

6.5. Macam-Macam Personal Hygiene

1. Memandikan klien di tempat tidur

a. Pengertian

Tindakan keperawatan yang dilakukan pada klien yang tidak mampu mandi secara sendiri dengan cara memandikan di tempat tidur.

b. Tujuan

1. Menjaga kebersihan tubuh,
2. Mengurangi infeksi akibat kulit kotor,
3. Memperlancar sistem peredaran darah
4. Menambah kenyamanan klien.

c. Alat dan Bahan

1. Baskom mandi dua buah, masing-masing berisi air dingin dan air hangat
2. Pakaian bersih 1 stel
3. Washlap 2 buah
4. Perlak dan handuk kecil 1 buah
5. Handuk besar 2 buah
6. Selimut mandi/ kain penutup
7. Celemek
8. Tempat tertutup untuk pakaian kotor
9. Sabun mandi
10. Bedak
11. Sarung tangan bersih
12. Rak handuk
13. Sketsel

d. Prosedure Kerja

Tahap Pra Interaksi
1. Pelajari data tentang klien/pasien sebagai persiapan melakukan pekerjaan
2. Siapkan alat sesuai dengan intruksi kerja 2
3. Dekatkan alat ke dekat pasien
4. Lakukan cuci tangan sebelum melakukan tindakan
Tahap Orientasi
5. Sampaikan salam terapeutik pada klien/pasien
6. Jelaskan intruksi kerja yang akan dilakukan
7. Tanyakan kesiapan pasien dalam tindakan intruksi kerja
Tahap Kerja
Memandikan pasien
8. Menjaga Privacy pasien
9. Memakai APD
10. Mengganti selimut pasien dengan selimut mandi kemudian melepas pakaian atas pasien dan menutupnya kembali dengan selimut mandi
11. Membentangkan perlak kecil & handuk kecil di bawah kepala, menawarkan pasien menggunakan sabun / tidak kemudian membersihkan muka, telinga dengan washlap basah dan mengeringkan dengan handuk yang berada di bawah

kepala
12. Menggulung perlak & handuk kemudian ditaruh di dalam tempat linen kotor yang tertutup
13. Memasang handuk besar di atas dada kemudian menurunkan selimut mandi ke bagian perut & kedua tangan klien diletakkan diatas handuk
14. Membasahi tangan klien dengan washlap air bersih, disabun kemudian dibilas dengan air hangat (lakukan dari ekstremitas terjauh klien) , dikeringkan dengan handuk yang berada diatasnya
15. Meletakkan kedua tangan yang sudah bersih dibagian kepala mengarah keatas, kemudian membersihkan dada dan perut pasien dari bawah handuk yang menutupi dada,dengan washlap basah, disabun, dibilas dengan air bersih dan dikeringkan dengan handuk yang berada diatas dada pasien
16. Memiringkan pasien kearah perawat dan membentangkan handuk di belakang punggung hingga bokong
17. Membasahi punggung hingga bokong dengan washlap, di sabun kemudian dibilas dengan air hangat & dikeringkan dan memberi bedak pada punggung
18. Mengambil handuk yang berada di bawah punggung untuk di taruh di rak handuk
19. Mengembalikan ke posisi telentang kemudian membantu pasien mengenakan pakaian atas
20. Mengambil handuk yang berada di atas dada untuk dimasukkan ke tempat linen kotor dan
21. Melepas pakaian bawah pasien dengan tetap menjaga privacy pasien
22. Mengambil handuk yang berada di rak handuk untuk di bentangkan dibawah kaki pasien
23. Menekuk kaki, kemudian membasahi kaki mulai dari pergelangan sampai pangkal paha disabun dibilas dengan air bersih kemudian dikeringkan dan melakukan tindakan yang sama untuk kaki yang lain
24. Mengambil handuk dibawah kaki pasien dan meletakkan ketempat linen kotor
Tahap Terminasi
25. Merapikan pasien dan membereskan peralatan
26. Evaluasi tindakan kepada pasien dan berpamitan dengan pasien
27. Melepaskan APD
28. Mencuci tangan
29. Mencatat kegiatan dalam lembar catatan keperawatan

2. Merawat rambut

a. Pengertian

Merupakan tindakan keperawatan yang dilakukan pada klien yang tidak mampu memenuhi kebutuhan untuk mencuci dan menyisir rambut.

b. Tujuan

1. Menghilangkan mikroorganisme kulit kepala
2. Menambah rasa nyaman
3. Membasmi kutu atau ketombe yang melekat pada kulit
4. Memperlancar sistem peredaran darah di bawah kulit

c. Alat dan Bahan

1. Handuk 2 buah
2. Talang
3. Peniti/penjepit
4. Kain pel
5. Baskom berisi air hangat
6. Gayung
7. Sampo
8. Sisir 2 buah
9. Kain kasa dan kapas
10. Ember kosong
11. Sarung tangan bersih
12. Bengkok berisi larutan desinfektan
13. Celemek
14. Alat pengering rambut

d. Prosedure Kerja

Tahap Pra Interaksi
1. Pelajari data tentang klien/pasien sebagai persiapan melakukan pekerjaan
2. Siapkan alat sesuai dengan intruksi kerja 2
3. Dekatkan alat ke dekat pasien
4. Lakukan cuci tangan sebelum melakukan tindakan
Tahap Orientasi
5. Sampaikan salam terapeutik pada klien/pasien
6. Jelaskan intruksi kerja 2 yang akan dilakukan
7. Tanyakan kesiapan pasien dalam tindakan intruksi kerja 2
Tahap Kerja
Mencuci rambut pasien
8. Menjaga Privacy pasien
9. Memakai APD
10. Mengganti selimut klien dengan selimut mandi
11. Mengatur posisi tidur pasien yaitu kepala di pinggir tempat tidur
12. Memasang handuk dibawah kepala kemudian memasang ember yang dialasi kain pel dan memasang talang dengan ujung berada di dalam ember
13. Menutup dada dengan handuk sampai leher kemudian menyisir rambut dari ujung kepangkal
14. Menutup lubang telinga dengan kapas dan mata dengan kain kassa
15. Menyiram dengan air hangat, menggosok/ memijit kulit kepala dan rambut dengan sampo meggunakan kasa dan membilas rambut dengan air sampai bersih
16. Melepas penutup telinga dan penutup mata kemudian mengangkat talang dan memasukkan kedalam ember bekas air mencuci rambut, mengeringkan rambut dengan handuk kemudian dengan pengering dan menyisir rambut
Tahap Terminasi
17. Merapikan pasien dan membereskan peralatan
18. Evaluasi tindakan kepada pasien dan berpamitan dengan pasien
19. Melepaskan alat pelindung diri

20. Mencuci tangan
21. Mencatat kegiatan dalam lembar catatan keperawatan

3. Oral Hygiene

a. Pengertian

Mulut yang sehat meliputi kebersihannya, kenyamanan dan kelembabanya. Perawatan mulut bertujuan untuk mencegah mulut dari penyakit dan kerusakan gigi. Klien yang dirawat lama dirumah sakit jarang sekali mendapat perawatan kebersihan mulut yang optimal. Idealnya klien merawat mulut secara rutin setiap kali sesudah makan, mandi dan bangun tidur.

Namun tidak semua klien mampu untuk melakukan perawatan mulut pada saat dia berada dirumah sakit, sehingga ada klien yang harus dibantu dalam perawatan mulut. Perawatan mulut diperlukan pada klien yang mendapatkan oksigenasi dan Naso Gastric Tube (NGT), demikian juga pada klien yang lama tidak menggunakan mulut. Pada klien yang tidak mampu melakukan perawatan mulut secara mandiri inilah yang harus mendapatkan bantuan dari perawat untuk merawat mulutnya. Pada kondisi ini klien menggunakan mulut untuk bernafas dan tidak memakan apapun dengan mulutnya, sehingga bakteri, sisa-sisa dari mukosa dan sekresi lain berkumpul dimulut, gigi dan bibir.

b. Tujuan

1. Menjaga kebersihan mulut
2. Meningkatkan nafsu makan

c. Alat dan Bahan

1. Tongue spatel
2. NaCl 0,9%
3. Kom kecil
4. Lidi kapas
5. Boraks Gliserin
6. Sikat gigi dan pasta gigi
7. Bengkok besar
8. Perlak
9. Gelas berisi air
10. Deppers
11. Alas perlak
12. Pinset/klem
13. Tisu
14. Handscoen bersih

d. Prosedur Tindakan Oral Hygiene (Memelihara Kebersihan Mulut)

FASE PRAINTERAKSI	
1	Mengidentifikasi kebutuhan/indikasi klien
2	Mencuci tangan
3	Menyiapkan alat
FASE ORIENTASI	
4	Mengucapkan salam & memperkenalkan diri
5	Menjelaskan tujuan prosedur tindakan
6	Menanyakan persetujuan klien untuk dilakukan tindakan
FASE KERJA	
7	Menjaga privasi (menutup sampiran), memakai handscoen
	Pada Klien Yang Sadar
8	Atur posisi klien dengan cara miringkan kepala klien dan bentangkan perlak serta alasnya dibawah dagu
9	Letakkan bengkok besar didekat pipi klien
10	Berikan air kepada klien untuk berkumur, tampung air bekas kumur-kumur pada bengkok.
11	Berikan sikat gigi yang telah dibubuhi pasta gigi secukupnya. Berikan kesempatan kepada klien untuk menyikat giginya sampai bersih. Jikatelah selesai berikan air bersih untuk berkumur kembali.
12	Letakkan sikat gigi pada gelas yang telah kosong
	Pada klien dengan penurunan kesadaran (tidak mampu menggosok gigi) :
13	Buka mulut klien, tangan kiri menekan lidah klien dengan tongue spatel/sudip lidah, kemudian tangan kanan menjepit deppers denganpinset , lalu dicelupkan kedalam NaCl dan diperas sedikit
14	Bersihkan rongga mulut seluruhnya sampai bersih mulai dari langit-langit, gigi bagian dalam ke bagian luar, gusi, lidah
15	Apabila klien mengalami stomatitis oleskan boraks gliserin pada bagian yang sakit dengan menggunakan lidi kapas
16	Bersihkan bibir dengan deppers yang telah dicelupkan kedalam NaCl
17	Oleskan boraks gliserin secukupnya pada bibir menggunakan lidi kapas
18	Angkat bengkok yang berisi, deppers, lidi kapas, tisu dan pinset yang kotor
19	Bersihkan daerah sekitar mulut dengan tisu
20	Angkat perlak dan alasnya dan letakkan di rak

FASE TERMINASI	
21	Merapikan klien dan alat 22
	Mengevaluasi respon klien
23	Mengucapkan salam
24	Mencuci tangan
25	Mendokumentasikan prosedur dalam catatan klien

4. Memotong Kuku

a. Pengertian

Memotong kuku adalah mengurangi panjang kuku tangan dan kuku kaki dengan menggunakan alat pemotong kuku agar kotoran tidak masuk ke dalam tubuh melalui kuku sehingga kuku tetap dalam keadaan sehat dan bersih. Menjaga kebersihan kuku merupakan aspek penting dalam mempertahankan perawatan diri karena kuman dapat masuk ke dalam tubuh melalui kuku.

b. Tujuan :

1. Mencegah infeksi
2. Memberikan rasa nyaman pada pasien
3. Mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam kuku yang panjang, bau kaki, dan cedera pada jaringan lunak

c. Alat dan Bahan :

1. Pengalas (perlak kecil)
2. Gunting kuku
3. Handuk
4. Bengkok berisi desinfektan
5. Baskom berisi air hangat
6. Sabun
7. Sikat kuku
8. Sarung tangan bersih
9. Aseton (jika perlu untuk menghilangkan cat kuku)
10. Kapas
11. Celemek

d. Prosedure Kerja

Tahap Pra Interaksi
1. Pelajari data tentang klien/pasien sebagai persiapan melakukan pekerjaan
2. Siapkan alat sesuai dengan intruksi kerja
3. Dekatkan alat ke dekat pasien
4. Lakukan cuci tangan sebelum melakukan tindakan
Tahap Orientasi
5. Sampaikan salam terapeutik pada klien/pasien
6. Jelaskan intruksi kerja 2 yang akan dilakukan
7. Tanyakan kesiapan pasien dalam tindakan intruksi kerja

Tahap Kerja
Menggunting kuku pasien
8. Menjaga privacy pasien
9. Memakai APD
10. Memasang pengalas di bawahnya kemudian merendam tangan dalam baskom berisi air hangat selama 1-2 menit untuk melunakkan kuku, jika kuku sangat kotor sikat kuku dan sabun kemudian bilas dengan air hangat dan keringkan dengan handuk
11. Meletakkan tangan diatas bengkok berisi lisol 3% supaya kuku tidak berserakan. Potong kuku pada jari tangan sesuai dengan lengkungan kuku
12. Setelah selesai, masukkan gunting kuku kedalam bengkok setelah dipotong, kikir kuku agar rapi, rata dan halus
Tahap Terminasi
13. Merapikan pasien dan membereskan peralatan
14. Evaluasi tindakan kepada pasien dan berpamitan dengan pasien
15. Melepaskan alat pelindung diri
16. Mencuci tangan
17. Mencatat kegiatan dalam lembar catatan keperawatan

BAB 7

PEMBERIAN NUTRISI PASIEN

7.1. Pemberian Nutrisi Pasien Per Oral

1. Pengertian

Pemberian nutrisi per oral adalah suatu proses pemenuhan makanan dan minuman melalui mulut klien. Ini adalah metode yang paling umum dan alami untuk memenuhi kebutuhan gizi.



Gambar. Pemberian Nutrisi Per Oral

2. Tujuan

1. Memenuhi kebutuhan gizi pasien.
2. Menjaga hidrasi tubuh.
3. Meningkatkan pemulihan kesehatan.
4. Mendorong kemandirian pasien dalam asupan makanan.

3. Indikasi

1. Pasien yang dapat menelan dan tidak memiliki kontraindikasi.
2. Pasien dalam pemulihan dari operasi atau penyakit yang tidak mempengaruhi saluran cerna.

4. Kontraindikasi

1. Kesulitan menelan (disfagia).
2. Muntah berulang atau risiko aspirasi.
3. Kondisi medis tertentu yang mempengaruhi asupan oral.

5. Hal Yang Perlu Dikaji :

Fungsi gastrointestinal, dan tipe diet yang dapat ditoleransi oleh klien, kemampuan klien menelan, nafsu makan klien, toleransi terhadap makanan, jenis makanan yang disukai dan yang tidak disukai, serta adanya alergi makanan.

6. Alat dan Bahan

1. Piring berisi makanan
2. Sendok
3. Garpu
4. Gelas minum yang berisi air hangat seta tutupnya
5. Sedotan
6. Tisu dalam tempatnya
7. Serbet
8. Baki untuk tempat membawa makanan

7. Prosedur Tindakan Pemberian Nutrisi Per Oral

FASE PRAINTERAKSI	
1	Mengidentifikasi kemampuan klien dalam pemenuhan nutrisi peroral 2
2	Mencuci tangan
3	Menyiapkan alat
FASE ORIENTASI	
4	Mengucapkan salam & memperkenalkan diri 5
5	Menjelaskan tujuan prosedur tindakan
6	Menanyakan persetujuan klien/keluarga untuk dilakukan tindakan
FASE KERJA	
7	Membawa makanan dengan menggunakan baki
8	Menjaga privasi klien
9	Mendekatkan alat-alat yang akan digunakan
10	Meminta klien berpartisipasi dalam tindakan (mengatur posisi)
11	Memberikan penghargaan klien atas kerjasamanya
12	Membentangkan Serbek di bawa dagu klien
13	Duduk dengan posisi yang memudahkan pekerjaan
14	Menawari minum kepada klien
15	Menyuapkan makanan sedikit-demi dengan menggunakan sendok atau garpu
16	Memperhatikan apakah makanan sudah ditelan habis klien
17	Setelah memberikan makanan klien diberikan minum
18	Membersihkan mulut klien dan sekitarnya dengan tissue
FASE TERMINASI	
19	Merapikan klien dan alat
20	Mengevaluasi respon klien
21	Mengucapkan terima kasih pada klien atas kerjasamanya
22	Mengucapkan salam
23	Mencuci tangan
24	Mendokumentasikan prosedur dalam catatan klien
TOTAL	

7.2. Pemberian Makan Melalui Selang Nasogastrik (NGT)

1. Pengertian

Pemasangan nasogastric tube (NGT) adalah pemasangan selang plastik lunak melalui nasofaring klien ke dalam lambung

Memberikan makanan melalui NGT adalah memasukkan formula cairan makanan atau obat dalam perut dengan cara memasukkan selang makanan lewat hidung atau mulut ke dalam perut pada pasien yang tidak bisa menelan dan tidak sadar

2. Pemberian makanan melalui selang selang NGT dilakukan pada pasien :

- Pasien yang tidak dapat makan menelan atau pasien yang tidak sadar
- Pasien yang harus meneruskan tidak mau makan sehingga membahayakan jiwanya misalnya pasien psikiatri (kelainan jiwa)
- Pasien yang muntah terus-menerus
- Bayi dengan berat badan lahir rendah atau BBLR prematur atau dismatur

3. Indikasi dan kontraindikasi Pemasangan NGT

- Indikasi
 - a. Pasien dengan distensi abdomen karena gas, darah dan cairan
 - b. Keracunan makanan minuman
 - c. Pasien yang membutuhkan nutrisi melalui ngt
 - d. pasien memerlukan ngt untuk diagnosis atau analisis isi lambung
- Kontraindikasi
 - a. Klien dengan sustained head trauma, maxillofacial injury atau anterior fossa skull fracture. Memasukkan NGT begitu saja melalui hidung maka potensial akan melalui cribofom plate ini akan menimbulkan penetrasi intracranial
 - b. Klient dengan riwayat isophageal stricture, esophageal varises dan Alkali ingestion juga beresiko untuk esophageal penetration.
 - c. Klien dengan koma, juga potensial vomiting dan aspirasi sewaktu memasukan NGT pada tindakan ini diperlukan tindakan proteksi seperti airway dipasang terlebih dahulu sebelum NGT
 - d. Pasien dengan gastric Bypass Surgery yang mana pasien ini mempunyai kantong lambung yang kecil untuk membatasi asupan makanan. konstruksi Bypass adalah dari kantong lambung yang kecil ke duodenum dan bagian-bagian usus kecil yang menyebabkan Malabsorpsi (mengurangi kemampuan untuk menyerap kalori dan nutrisi)

4. Pertolongan pemberian Makan Melalui NGT

- Alat dan bahan
 - a. Selang nasogastric NGT steril sesuai kebutuhan(Bayi : no. 5 - 8, Anak: no.10-14, Dewasa: no. 16-18
 - b. Handscone steril 1 pasang
 - c. Pinset anatomi steril 1 pasang
 - d. Spuit 5 cc
 - e. Jelly atau Vaseline
 - f. Stetoskop
 - g. Plester perekat dan gunting
 - h. Cacing berisi kertas lakmus
 - i. Lidi watten atau cotton bud
 - j. Mangkok berisi air matang (bila tidak ada stetoskop)
 - k. Makanan dalam bentuk cair
 - l. Spuit 20-50 ml
 - m. Corong makan (Bila perlu)
 - n. Gelas berisi air matang untuk membilas
 - o. Obat-obatan(bila ada)
 - p. Baskom berisi larutan klorin 0,5%
 - q. Sampah medis dan nonmedis
 - r. Buku catatan dan alat tulis

5. Prosedur tindakan pemasangan dan pemberian makan menggunakan NGT

FASE PRAINTERAKSI	
1	Mengecek program terapi medis
2	Mencuci tangan
3	Menyiapkan alat
FASE ORIENTASI	
4	Mengucapkan salam & memperkenalkan diri 5
5	Menjelaskan tujuan prosedur tindakan
6	Menanyakan persetujuan klien/keluarga untuk dilakukan tindakan
FASE KERJA	
7	Menjaga privasi klien
8	Mendekatkan alat-alat yang akan digunakan
	Pemasangan NGT
9	Bantu pasien untuk posisi setengah duduk (semi-Fowler).
10	Bersihkan daerah hidung dengan cotton bud
11	pasang pengalas di daerah dada
12	letakkan bengkok di dekat pasien
13	pakai sarung tangan steril untuk mencegah kontaminasi dan infeksi.
14	Ukur selang untuk memperkirakan panjang pemasangan dan tandai titik dengan plester kecil atau klem. Adapun 2 metode standar pengukuran panjang adalah sebagai berikut : - Mengukur dari hidung ke daun telinga dan kemudian ke ujung prosesus xifoideus - Mengukur dari hidung ke daun telinga dan kemudian ke titik tengah antara prosesus xifoideus dan umbilikus - Berikan jelly pada ujung selang dan tutup NGT atau klem - Masukkan melalui hidung secara perlahan-lahan sambil pasien dianjurkan untuk menelan dan perhatikan reaksi pasien (hentikan tindakan bila pasien batuk/ bersin/ muntah)
15	Tentukan apakah pipa tersebut benar-benar sudah masuk ke dalam lambung dengan cara berikut - Masukkan ujung selang yang diklem ke dalam baskom berisi air, buka klem atau tutup NGT dan perhatikan jika ada gelembung berarti ujung NGT masuk ke dalam paru, dan jika tidak ada gelembung berarti sudah masuk ke dalam lambung.setelah itu, diklem/dilipat kembali - Masukkan udara dengan spuit 3 cc kedalam lambung melalui NGT dan dengarkan dengan stetoskop bila terdengar bunyi berarti sudah masuk ke lambung, setelah itu tarik kembali spuit untuk mengeluarkan udara yang sudah dimasukkan
16	Stabilkan selang dengan menahannya atau memplesternya ke pipi, bukan ke dahi karena kemungkinan terjadinya kerusakan pada lubang hidung. guna mempertahankan letak yang tepat ukur dan catat panjang selang yang dimasukkan dari hidung atau mulut ke lubang bagian distal saat selang dipasang untuk pertama kalinya. Periksa ulang pengukuran ini setiap kali sebelum pemberian makan

17	Setelah selesai pemasangan NGT lakukan tindakan pemberian makanan dengan cara pasang spuit pada ujung pipa
18	Berikan makanan dalam bentuk cair yang tersedia dengan cara menghangatkan dahulu makanan cair sesuai dengan suhu ruangan. untuk memulai aliran, berikan dorongan lembut dengan plunger tetapi kemudian lepaskan pluger dan biarkan air mengalir ke dalam lambung berdasarkan gravitasi.
19	Bilas selang dengan air steril (1/2 ml untuk selang kecil, 5- 15 ml/ lebih untuk selang yang besar)
20	tutup atau klem selang untuk mencegah hilangnya makanan
FASE TERMINASI	
21	Merapikan klien dan alat
22	Mengevaluasi respon klien
23	Mengucapkan terima kasih pada klien atas kerjasamanya
24	Mengucapkan salam
25	Mencuci tangan
26	Mendokumentasikan reaksi pasien pasca pemberian makanan

BAB 8

MEMBANTU PASIEN BAK DAN BAB

8.1. Membantu Pasien Bak Dan Bab

1. Pengertian

Membantu pasien BAK yaitu membantu pasien buang air kecil menggunakan urinal yang diterapkan pada pasien yang tidak mampu buang air kecil sendiri di kamar mandi.

2. Tujuan

- Untuk pemantauan pola eliminasi
- Pengambilan urine untuk pemeriksaan

3. Alat dan Bahan

- Urinal
- Pengalas
- Tisu
- Botol berisi air hangat

4. Prosedur Tindakan Membantu Pasien BAK di Atas Tempat Tidur

FASE PRAINTERAKSI	
1	Mengidentifikasi kebutuhan/indikasi klien
2	Mencuci tangan
3	Menyiapkan alat
FASE ORIENTASI	
4	Mengucapkan salam & memperkenalkan diri
5	Menjelaskan tujuan prosedur tindakan
6	Menanyakan persetujuan klien untuk dilakukan tindakan
FASE KERJA	
7	Menjaga privasi klien
8	Memakai sarung tangan
9	Memasang pelak dibawah bokong klien
10	Melepaskan pakaian bawah klien
11	Mengatur posisi pasien (dorsal recumbent), tergantung kenyamanan klien
12	Memasang urinal di bawah gluteal/pinggul atau di antara kedua paha
13	Menganjurkan klien untuk berkemih
14	Menyiram genitalia (penis) klien dengan air hangat
15	Mengeringkan genitalia dengan tisu
16	Memasang kembali pakaian bawah klien
FASE TERMINASI	
17	Merapikan klien dan alat
18	Mengevaluasi respon klien terhadap tindakan
19	Memberi salam
20	Mencuci tangan
21	Mendokumentasikan hasil kegiatan

8.2. Membantu Pasien BAB

1. Pengertian

Membantu pasien BAB yaitu membantu pasien buang air besar menggunakan pispot yang dilakukan pada pasien yang tidak mampu buang air besar di toilet. Pasien dibantu menggunakan pispot (penampung untuk buang air besar di tempat tidur).

2. Tujuan

- Untuk pemantauan pola eliminasi
- Pemeriksaan diagnostik

3. Alat dan Bahan

- Pispot
- Pengalas
- Kapas cebok
- Bengkok
- Tisu
- Air bersih dalam tempatnya (botol)
- Sarung tangan

4. Prosedur Tindakan Membantu Pasien Bab Di Atas Tempat Tidur

FASE PRAINTERAKSI	
1	Mengidentifikasi kebutuhan/indikasi klien
2	Mencuci tangan
3	Menyiapkan alat
FASE ORIENTASI	
4	Mengucapkan salam & memperkenalkan diri
5	Menjelaskan tujuan prosedur tindakan
6	Menanyakan persetujuan klien untuk dilakukan tindakan
FASE KERJA	
7	Menjaga privasi klien
8	Memakai sarung tangan
9	Memasang perlak dibawah bokong klien
10	Melepaskan pakaian bawah klien
11	Menempatkan pispot di antara pengalas dan gluteal dengan posisi lubang pispot tepat di bawah rektum
12	Menanyakan kepada klien apakah sudah merasa nyaman, bila belum atur kembali posisi pispot sesuai dengan kebutuhan
13	Berikan keleluasaan klien untuk BAB
14	Observasi karakteristik feses (Konsistensi: lembek, encer, keras, warna)
15	Menyiram daerah anus dan genetalia dengan air bersih
16	Membersihkan daerah anus dan genetalia dengan kapas cebok dan dikeringkan dengan tisu(kapas bekas cebok dan tisu dibuang dibengkok yang dialasi plastik)
17	Mengambil pispot dibawah bokong pasien
18	Mengambil perlak dibawah bokong klien

FASE TERMINASI	
16	Merapikan klien dan alat
17	Mengevaluasi respon klien terhadap tindakan
18	Memberi salam
19	Mencuci tangan
20	Mendokumentasikan hasil kegiatan

BAB 9

PERAWATAN KATETER

9.1. Pengertian

Perawatan kateter adalah suatu tindakan keperawatan dalam memelihara kateter dengan antiseptik untuk membersihkan ujung uretra dan selang kateter bagian luar serta mempertahankan kepatenan posisi kateter

9.2. Tujuan

1. Menjaga kebersihan saluran kencing
2. Mempertahankan kepatenan (fiksasi) kateter
3. Mencegah terjadinya infeksi
4. Mengendalikan infeksi

9.3. Indikasi

- a. Kelainan yang terpasang kateter lebih dari 7 hari
- b. Klien yang tidak memerlukan pemasangan kateter menetap

9.4. Tindakan Perawatan Kateter

a. Alat Dan Bahan

1. Sarung tangan steril
2. Pengalas
3. Bengkok
4. Lidi kapas steril
5. Kapas steril
6. Antiseptik (betadine)
7. Aquades / air hangat
8. Korentang
9. Plester
10. Gunting
11. Alkohol
12. Pinset
13. Bengkok

b. Prosedur Tindakan Perawatan Kateter

Tahap Pra Interaksi	
1.	Pelajari data tentang klien/pasien sebagai persiapan melakukan pekerjaan
2.	Siapkan alat sesuai dengan intruksi kerja
3.	Dekatkan alat ke dekat pasien
4.	Lakukan cuci tangan sebelum melakukan tindakan
Tahap Orientasi	
5.	Sampaikan salam terapeutik pada klien/pasien
6.	Jelaskan intruksi kerja yang akan dilakukan
7.	Tanyakan kesiapan pasien dalam tindakan intruksi kerja
Tahap Kerja	
Melakukan perawatan kateter pada pria	

8.	Menjaga privacy pasien
9.	Memakai APD
10.	Oles alkohol pada plester dan buka dengan pinset
11.	Buka balutan pada Kateter
12.	Pakai sarung tangan steril
13.	Perhatikan kebersihan dan tanda-tanda infeksi dari ujung penis serta kateter
14.	Bersihkan ujung uretra dan kateter memakai kapas steril yang telah dibasahi dengan aquabides atau air hangat dengan arah menjauhi uretra
15.	Oles ujung uretra dan kateter memakai lidi kapas+ Betadine dengan arah menjauhi uretra
16.	Balut ujung penis dan kateter dengan kasa steril, kemudian plester
17.	Posisikan kateter ke arah perut dan plester
Melakukan perawatan kateter pada wanita	
18.	Atur posisi klien ke posisi dorsal recumbent
19.	Letakkan perlak atau pengalas dan bengkok
20.	gunakan sarung tangan steril
21.	buka daerah labia mayora
22.	kaji daerah vulva dan daerah sekitarnya seperti adanya, perih, radang, pembengkakan, adanya cairan atau kotoran
23.	Bersihkan daerah labia mayora dan minora dengan kapas cairan antiseptik 1 kapas untuk 1 kali usapan
24.	Bersihkan ujung kateter dengan meatus sepanjang 10 cm dengan kapas cairan antiseptik, bagian anterior dan posterior
Tahap terminasi	
25.	Membereskan alat,rapikan pasien
26.	Evaluasi tindakan kepada pasien dan berpamitan dengan pasien
27.	Melepaskan alat pelindung diri
28.	Mencuci tangan
29.	Mencatat kegiatan dalam lembar catatan kegiatan

BAB 10

LATIHAN NAPAS DALAM DAN BATUK EFEKTIF

10.1. Pengertian

Latihan nafas dalam adalah bernapas untuk pengambilan oksigen maksimal dan latihan batuk efektif adalah batuk untuk pengeluaran sekret yang terakumulasi dan mengganggu di saluran pernafasan dengan cara dibatukkan. Latihan nafas dalam dan batuk dilakukan pada klien yang mengalami gangguan fungsi respirasi.

Batuk efektif adalah suatu metode batuk dengan benar, dimana klien dapat menghemat energi sehingga tidak mudah lelah mengeluarkan dahak secara maksimal. Batuk merupakan gerakan refleks yang bersifat reaktif terhadap masuknya benda asing dalam saluran pernapasan. Gerakan ini terjadi atau dilakukan tubuh sebagai mekanisme alamiah terutama untuk melindungi paru paru.

Gerakan ini pula yang kemudian dimanfaatkan kalangan medis sebagai terapi untuk menghilangkan lendir yang menyumbat saluran pernapasan akibat sejumlah penyakit. Itulah yang dimaksud pengertian batuk efektif.

Batuk efektif merupakan batuk yang dilakukan dengan sengaja. Namun dibandingkan dengan batuk biasa yang bersifat refleks tubuh terhadap masuknya benda asing dalam saluran pernapasan, batuk efektif dilakukan melalui gerakan yang terencana atau dilatihkan terlebih dahulu. Dengan batuk efektif, maka berbagai penghalang yang menghambat atau menutup saluran pernapasan dapat dihilangkan.

10.2. Indikasi :

1. Latihan Nafas Dalam dilakukan pada :
 - a. Klien dengan gangguan paru obstruktif maupun restriktif
 - b. Klien pada tahap penyembuhan dari pembedahan thorax
 - c. Untuk metode relaksasi
2. Batuk Efektif dilakukan pada :
 - a. Klien dengan gangguan saluran nafas akibat akumulasi sekret
 - b. Klien yang akan dilakukan pemeriksaan diagnostik sputum
 - c. Klien setelah menggunakan bronkodilator

10.3. Tujuan :

Tujuan latihan nafas dalam dan batuk efektif adalah :

1. Meningkatkan kapasitas paru
2. Mencegah atelektasis
3. Membebaskan jalan nafas dan akumulasi sekret
4. Mengeluarkan sputum untuk pemeriksaan diagnostik
5. Mengurangi sesak nafas akibat akumulasi sekret

10.4. Tindakan Latihan Nafas Dalam dan Batuk Efektif

Alat dan Bahan :

1. Kertas tissue
2. Bengkok
3. Perlak/pengalas

4. Sputum pot
5. Air minum hangat
6. Sarung tangan
7. Antiseptik

Prosedur Tindakan Latihan Napas Dalam dan Batuk Efektif

FASE PRAINTERAKSI	
1	Mengidentifikasi kebutuhan/indikasi klien
2	Mencuci tangan
3	Menyiapkan alat
FASE ORIENTASI	
4	Mengucapkan salam & memperkenalkan diri
5	Menjelaskan tujuan prosedur tindakan
6	Menanyakan persetujuan klien untuk dilakukan tindakan
FASE KERJA	
7	Memasang tirai/penutup
8	Mengatur posisi yang nyaman (semi fowler atau supine)
9	Memakai sarung tangan
10	Meminta klien meletakkan satu tangan di dada dan satu tangan di abdomen
11	Melatih klien melakukan nafas perut (menarik nafas dalam melalui hidung hingga 3 hitungan, jaga mulut tetap tertutup), tetap rileks, jangan melengkungkan punggung dan konsentrasi pada pengembangan abdomen
12	Meminta klien menahan nafas hingga 3 hitungan
13	Meminta menghembuskan nafas perlahan dalam 3 hitungan (lewat mulut, bibir seperti meniup)
14	Memasang perlak/alas dan bengkak (di pangkuan klien bila duduk atau di dekat mulut bila tidur miring)
15	Meminta klien untuk melakukan nafas dalam 2 kali, yang ke-3: inspirasi, tahan nafas dan batukkan dengan kuat
16	Menampung lendir dalam sputum pot
FASE TERMINASI	
17	Merapikan klien dan alat
18	Melepaskan sarung tangan dan mencuci tangan
19	Mengevaluasi respon klien
20	Mengucapkan salam
21	Mendokumentasikan hasilnya

BAB 11

PEMBERIAN KOMPRES PADA PASIEN

11.1. Pengertian

Kompres adalah metode pemeliharaan suhu tubuh dengan menggunakan cairan atau alat yang dapat menimbulkan hangat atau dingin pada bagian tubuh yang memerlukan.

11.2. Jenis-Jenis Kompres

1. Kompres panas
2. Kompres dingin

11.3. Tujuan

1. Kompres Panas
 - a. Memperlancar sirkulasi darah
 - b. Mengurangi rasa sakit
 - c. Memberi rasa hangat, nyaman, dan tenang pada klien
 - d. Merangsang peristaltik usus
2. Kompres Dingin
 - a. Menurunkan suhu tubuh
 - b. Mencegah peradangan meluas
 - c. Mengurangi kongesti
 - d. Mengurangi perdarahan setempat
 - e. Mengurangi rasa sakit pada daerah setempat

11.4. Indikasi

1. Kompres Panas
 - a. Klien yang kedinginan (suhu tubuh yang rendah)
 - b. Klien dengan perut kembung
 - c. Klien yang punya penyakit peradangan, seperti radang persendian
 - d. Spasme otot
 - e. Adanya abses, hematoma
2. Kompres Dingin
 - a. Klien dengan suhu tubuh yang tinggi
 - b. Klien dengan batuk dan muntah darah
 - c. Pasca tonsilektomi
 - d. Radang, memar

11.5. Prosedur Tindakan Kompres

1. Cara Pemberian Kompres Panas
 - a. Kompres Panas Basah
 - 1) Persiapan Alat
 - a) Kom berisi air hangat sesuai kebutuhan
 - b) Kain kompres atau waslap
 - c) Handuk kecil kering
 - d) Pengalas
 - e) Sarung tangan bersih

- 2) Prosedur
 - a) Dekatkan alat-alat kedekat klien, perhatikan privasi klien, cuci tangan dan atur posisi klien yang nyaman
 - b) Kenakan sarung tangan
 - c) Pasang pengalas dibawah daerah yang akan dikompres
 - d) Basahi kain kompres dengan air hangat suhu kira-kira 40 C, peras kain/waslap
 - e) Meletakkan kain kompres pada area yang akan dikompres
 - f) Menutup kain kompres dengan handuk kering/kain yang bersih
 - g) Bila kain kompres telah kering, kurang lebih(5-10 menit) atau suhu kain kompres relative menjadi dingin, maka masukkan kembali kain kompres kedalam cairan kompres dan letakkan kembali di daerah yang dikompres, lakukan berulang hingga efek yang diinginkan tercapai
 - h) Keringkan daerah yang dikompres dengan handuk
 - i) Lepaskan sarung tangan, atur kembali posisi klien dengan posisi yang nyaman, bereskan semua alat-alat untuk disimpan kembali, cuci tangan dan dokumentasikan tindakan ini beserta responnya
- 3) Hal yang perlu diperhatikan
 - a) kain kompres harus diganti pada waktunya dan suhu kompres di pertahankan tetap hangat
 - b) cairan jangan terlalu panas, hindarkan agar kulit jangan sampai kulit terbakar
 - c) kain kompres harus lebih besar dari pada area yang akan dikompres
 - d) untuk kompres hangat pada luka terbuka, peralatan harus steril. Pada luka tertutup seperti memar atau bengkak, peralatan tidak perlu steril karena yang penting bersih.

b. Kompres panas kering menggunakan buli-buli panas

- 1) Persiapan alat
 - a) Buli-buli panas dan sarungnya
 - b) Termos berisi air panas
 - c) Lap kerja
- 2) Prosedur
 - a) Persiapan alat, cuci tangan
 - b) Lakukan pemasangan terlebih dahulu pada buli-buli panas dengan cara : mengisi buli-buli dengan air panas, kencangkan penutupnya kemudian membalik posisi buli-buli berulang-ulang, lalu kosongkan isinya.
 - c) Isi buli-buli dengan air panas sebanyak kurang lebih setengah bagian dari buli- buli tersebut. Lalu keluarkan udaranya dengan cara: letakkan atau tidurkan buli- buli di atas meja atau tempat datar, bagian atas buli-buli di lipat sampai kelihatan permukaan air di leher buli-buli, kemudian penutup buli-buli di tutup dengan rapat/benar.
 - d) Periksa apakah buli-buli bocor atau tidak lalu keringkn dengan lap kerja dan masukkan ke dalam sarung buli-buli
 - e) buka area yang akan di kompres dan atur yang nyaman pada klien

- f) Pasang pernak pengalas pada bagian tubuh yang akan di kompres
- g) Letakkan atau pasang buli-buli pada area yang akan dikompres
- h) Kaji secara teratur kondisi klien untuk mengetahui kelainan yang timbul akibat pemberian kompres dengan buli-buli panas, seperti kemerahan, ketidak nyamanan, kebocoran, dsb.
- i) Ganti buli-buli panas setelah 30 menit di isi dengan air panas lagi, sesuai yang di kehendaki
- j) Bereskan alat alat bila sudah selesai, Cuci tangan, Dokumentasikan
- 3) Hal-hal yang perlu diperhatikan
 - a) Buli-buli panas tidak boleh diberikan pada klien pendarahan
 - b) Pemakaian buli-buli panas ada bagian bdomen, tutup buli-buli mengarah ke atas atau ke samping
 - c) Pada bagian kaki, tutup buli-buli mengarah ke bawah atau ke samping
 - d) Buli-buli harus di periksa dulu, ada tidak cincin karet pada penutupnya

2. Cara Pemberian Kompres Dingin

a. Kompres dingin basah dengan air biasa/air es

- 1) Persiapan alat
 - a) Kom kecil berisi air biasa/air es
 - b) Pernak pengalas
 - c) Beberapa buah waslap/kain kompres dengan ukuran tertentu
 - d) Handuk kecil kering
 - e) Sampiran bila perlu
 - f) Selimut bila perlu
- 2) Prosedur
 - a) Dekatkan alat-alat ke klien, Pasang sampiran bila perlu
 - b) Kenakan sarung tangan
 - c) Pasang pengalas pada area yang akan dikompres
 - d) Masukkan waslap/kain kompres kedalam air biasa atau air es lalu diperas sampai lembab
 - e) Letakkan waslap/kain kompres tersebut pada area yang akan dikompres
 - f) Menutup kompres dingin dengan handuk kering.
 - g) Lakukan kompres selama kurang lebih (5-10 menit) atau ketika kain penutup basah
 - h) Keringkan daerah yang dikompres dengan handuk
 - i) Rapikan klien dan bereskan alat-alat bila prasad ini sudah selesai, Cuci tangan,Dokumentasikan
- 3) Hal yang harus diperhatikan
 - a) Bila suhu tubuh 39°C/lebih, tempat kompres dilipat paha dan ketiak
 - b) Pada pemberian kompres dilipat paha, selimut diangkat dan dipasang busur selimut di atas dada dan perut klien agar seprei atas tidak basah

b. Kompres dingin kering dengan kirbat es (eskap)

- 1) Persiapan alat
 - a) Kirbat es/eskap dengan sarungnya
 - b) Kom berisi berisi potongan-potongan kecil es
 - c) Lap kerja
 - d) Perlak pengalas
- 2) Prosedur
 - a) Bawa alat-alat ke dekat klien, Cuci tangan
 - b) Isi kirbat es dengan potongan es sebanyak kurang lebih setengah bagian dari kirbat tersebut
 - c) Keluarkan udara dari eskap dengan melipat bagian yang kosong, lalu di tutup rapat
 - d) Periksa dengan teliti apakah kirbat es bocor atau tidak
 - e) Keringkan eskap dengan lap, lalu masukkan ke dalam sarungnya
 - f) Buka area yang akan di kompres dan atur yang nyaman pada klien
 - g) Pasang perlak pengalas pada bagian tubuh yang akan di kompres
 - h) Letakkan eskap pada bagian yang memerlukan kompres
 - i) Kaji keadaan kulit setiap 20 menit terhadap nyeri, mati rasa, dan suhu tubuh
 - j) Angkat eskap bila sudah selesai
 - k) Atur posisi klien kembali pada posisi yang nyaman, bereskan alat setelah selesai melakukan prasad ini, cuci tangan, dokumentasikan
- 3) *Hal-hal yang perlu diperhatikan*
 - a) Bila klien kedinginan atau sianosis, kirbat es harus segera di angkat
 - b) Selama pemberian kirbat es, perhatikan kult klien terhadap keberadaan iritasi dan lain-lain
 - c) Pemberian kirbat es untuk menurunkan suhu tubuh, maka suhu tubuh harus di control setiap 30-60 menit.bila suhu sudah turun kompres di hentikan
 - d) Bila tdak ada kirbat es bias menggunakan kantong plastic
 - e) Bila es dalam kirbat es sudah mencair harus segera diganti

Prosedur Tindakan Kompres Panas

FASE PRAINTERAKSI	
1	Mengidentifikasi kebutuhan/indikasi klien
2	Menyiapkan alat sesuai instruksi kerja
3	Mendekatkan alat kedekat pasien
4	Mencuci tangan sebelum melakukan tindakan
FASE ORIENTASI	
5	Mengucapkan salam & memperkenalkan diri
6	Menjelaskan tujuan prosedur tindakan
7	Menanyakan persetujuan klien untuk dilakukan tindakan

FASE KERJA	
Kompres Panas Basah	
8	Mengatur posisi klien yang nyaman
9	Menjaga privasi klien
10	Mengenakan sarung tangan
11	Memasang pengalas dibawah daerah yang akan dikompres
12	Membasahi kain kompres dengan air hangat suhu kira-kira 40 C, peras kain kompres / waslap
13	Meletakkan kain kompres pada area yang akan dikompres
14	Menutup kain kompres dengan handuk kering/kain yang bersih
15	Bila kain kompres telah kering, kurang lebih(5-10 menit) atau suhu kain kompres relative menjadi dingin, maka masukkan kembali kain kompres kedalam cairan kompres dan letakkan kembali di daerah yang dikompres, lakukan berulang hingga efek yang diinginkan tercapai
16	Mengeringkan daerah yang dikompres dengan handuk
Kompres Panas Kering Menggunakan Buli-Buli Panas	
17	Mengisi buli-buli dengan air panas sebanyak kurang lebih setengah bagian dari buli-buli tersebut.
18	Mengeluarkan udara dari dalam buli-buli dengan cara meletakkan atau menidurkan buli-buli di atas meja atau tempat datar, tekuk bagian atas buli-buli sampai kelihatan permukaan air di leher buli-buli, kemudian tutup buli-buli.
19	Memeriksa apakah buli-buli bocor atau tidak lalu keringkan dengan lap kerja dan masukkan ke dalam kantong/sarung buli-buli
20	Membuka area yang akan di kompres dan atur yang nyaman pada klien
21	Memasang perlak pengalas pada bagian tubuh yang akan di kompres
22	Meletakkan atau pasang buli-buli pada area yang akan dikompres
23	Mengkaji secara teratur kondisi klien untuk mengetahui kelainan yang timbul akibat pemberian kompres dengan buli-buli panas, seperti kemerahan, ketidak nyamanan, kebocoran, dsb.
24	Mengganti buli-buli panas setelah 30 menit di isi dengn air panas lagi, sesuai yang di kehendaki
FASE TERMINASI	
25	Merapikan klien dan alat
26	Mengevaluasi respon klien
27	Mengucapkan salam
28	Mencuci tangan
29	Mendokumentasikan prosedur dalam catatan klien

Prosedur Tindakan Kompres Dingin

FASE PRAINTERAKSI	
1	Mengidentifikasi kebutuhan/indikasi klien
2	Menyiapkan alat sesuai instruksi kerja
3	Mendekatkan alat kedekat pasien
4	Mencuci tangan sebelum melakukan tindakan
FASE ORIENTASI	
5	Mengucapkan salam & memperkenalkan diri
6	Menjelaskan tujuan prosedur tindakan
7	Menanyakan persetujuan klien untuk dilakukan tindakan
FASE KERJA	
Kompres Dingin Basah Dengan Air Biasa/Air Es	
8	Mengatur posisi klien yang nyaman
9	Menjaga privasi klien
10	Mengenakan sarung tangan
11	Memasang pengalas pada area yang akan dikompres
12	Masukkan waslap/kain kompres kedalam air biasa atau air es lalu diperas sampai lembab
13	Meletakkan waslap/kain kompres tersebut pada area yang akan dikompres
14	Menutup kompres dingin dengan handuk kering
15	Melakukan kompres selama kurang lebih (5-10 menit) atau ketika kain penutup basah
16	Mengeringkan daerah yang dikompres dengan handuk
Kompres Dingin Kering Dengan Kirbat Es (Eskap)	
17	Mengisi kirbat es dengan potongan es sebanyak kurang lebih setengah bagian dari kirbat tersebut
18	Mengeluarkan udara dari eskap dengan melipat bagian yang kosong, lalu ditutup rapat
19	Memeriksa dengan teliti apakah kirbat es bocor atau tidak
20	Mengeringkan eskap dengan lap, lalu masukkan ke dalam sarungnya
21	Buka area yang akan di kompres dan atur yang nyaman pada klien
22	Memasang perlak pengalas pada bagian tubuh yang akan di kompres
23	Meletakkan eskap pada bagian yang memerlukan kompres
24	Mengobservasi reaksi yang timbul pada klien, misalnya iritasi, nyeri, mati rasa, dan suhu tubuh
25	Angkat eskap bila sudah selesai/tidak dibutuhkan lagi
FASE TERMINASI	
26	Merapikan klien dan alat
27	Mengevaluasi respon klien
28	Mengucapkan salam
29	Mencuci tangan
30	Mendokumentasikan prosedur dalam catatan klien

BAB 12

PEMBERIAN OBAT

12.1. Pengertian

Obat merupakan substansi yang diberikan kepada manusia sebagai perawatan, pengobatan, atau pencegahan terhadap berbagai gangguan yang terjadi dalam tubuh.

Memberikan obat dengan aman dan akurat merupakan salah satu tanggung jawab perawat. Tanggung jawab perawat dalam pengobatan adalah :

1. Memahami reaksi dan efek samping obat
2. Memberikan obat dengan benar
3. Memonitor respon klien
4. Membantu klien menggunakan obat dengan benar

12.2. Cara penggunaan obat

Obat dapat digunakan melalui berbagai macam cara. Cara yang dipakai didasarkan pada bentuk obat, efek yang diinginkan baik fisik maupun mental

1. Oral

a. Oral

Pemberian obat melalui mulut merupakan cara paling mudah dan paling sering digunakan. Obat yang digunakan biasanya memiliki onset yang lama dan efek lebih lama

b. Sublingual

Obat yang diberikan melalui sublingual, dirancang agar segera diabsorpsi setelah diletakan dibawah lidah. Obat ini tidak boleh ditelan, karena jika ditelan efek yang diharapkan tidak dapat dicapai. Selain itu klien tidak diperkenankan minum sebelum obat menjadi larut. Obat yang biasa diberikan antara lain : Nitroglyserin

c. Buccal

Obat yang solid diberikan pada mukosa pipi hingga obat terlarut. Bila obat diberikan beberapa kali, klien diminta untuk menggunakan sisi pipi secara bergantian, untuk mencegah terjadinya iritasi. Klien tidak boleh mengunyah atau menelan obat. Obat ini hanya bekerja pada mukosa atau jika telah tertelan akan bekerja secara sistemik.

Meskipun pemberian obat melalui mulut lebih mudah, serta disukai oleh klien, akan tetapi ada beberapa klien tidak diperkenankan melakukannya. Pemberian obat melalui oral tidak diperbolehkan pada klien yang memiliki gangguan fungsi gastrointestinal, motilitas menurun (misalnya setelah anestesi general), serta pasca operasi sistem gastrointestinal. Selain itu medikasi oral juga tidak diperkenankan pada klien dengan gastric suction.

Kerugian yang terdapat pada medikasi oral adalah klien yang tidak sadar sepenuhnya, tidak dapat menelan atau meletakkan obat dibawah lidah. Medikasi oral dapat menimbulkan rasa tidak enak dan dapat merusak lintasan gastrointestinal, perubahan warna pada gigi.

2. Parenteral

Pemberian obat melalui parenteral merupakan pemberian obat melalui jaringan tubuh. Ada beberapa cara pemberian obat melalui parenteral :

a. Subcutan (SC)

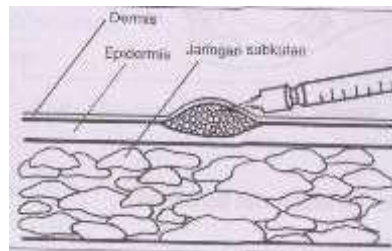
Yaitu obat disuntikan melalui jaringan antara dermis dan kulit. Tindakan ini biasanya berupa pemberian/injeksi obat insulin, dengan sudut penyuntikan 45° dari permukaan kulit. Lokasi penyuntikan yaitu pada lengan atas sebelah luar (area skapula), perut, paha bagian luar/depan (ventrogluteal, dan dorsogluteal) atau pada daerah dada.



Gambar. Penyuntikan Subcutan

b. Intradermal (ID)

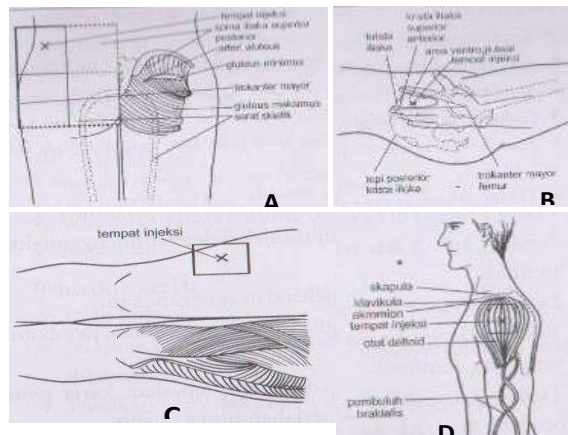
Yaitu obat disuntikan melalui dermis, dibawah epidermis. Tindakan ini biasanya berupa skintest/pemberian obat antibiotik yang dilakukan untuk mengetahui reaksi alergi terhadap obat yang diberikan. Tindakan ini dilakukan dengan sudut penyuntikan 15-20° lokasi penyuntikan lengan bawah bagian dalam atau bagian lain yang dianggap perlu.



Gambar. Penyuntikan Intracutan

c. Intramuskular (IM)

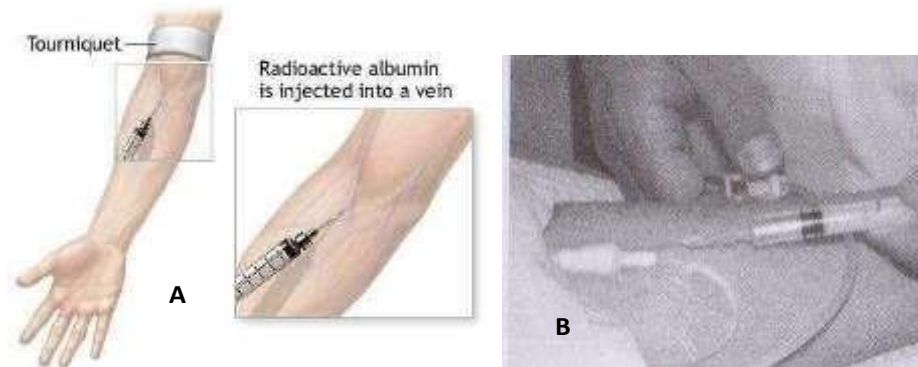
Yaitu obat disuntikan ke jaringan otot. Lokasi penyuntikan dilakukan pada daerah yang memiliki otot yang tebal, antara lain pada otot pangkal lengan, otot paha (1/3 tengah bagian luar, otot bokong pada 1/3 bagian dari spina iliaca anterior superior).



Gambar. Posisi Penyuntikan Intramuscular. A. Daerah lokasi intramuscular. B. Daerah ventrogluteal. C. Daerah vastus lateralis. D. Daerah deltoid

d. Intravena (IV)

Yaitu obat disuntikan melalui vena. Pemberian obat lewat intravena bisa dilakukan secara langsung lewat vena, lewat selang intravena maupun lewat wadah cairan intravena, tergantung pada kebutuhan mediasi dari klien. Pemberian obat melalui wadah cairan intravena dilakukan dengan infus IV. Pemberian obat dengan cara ini dilakukan jika obat yang diberikan berjumlah cukup besar dan membutuhkan waktu yang lama untuk menginjeksikannya.



Gambar. A. Injeksi IV langsung. B. Injeksi IV melalui selang infus
Pemberian obat parenteral, merupakan pilihan jika pemberian obat melalui mulut merupakan kontraindikasi. Obat yang akan diberikan akan lebih cepat terabsorpsi dibandingkan dengan oral atau topikal.

Beberapa kerugian ditimbulkan oleh pemberian obat melalui parenteral, antara lain: adanya resiko untuk terjadinya infeksi, obat lebih mahal, klien mengalami tusukan jarum. Selain itu adanya resiko terjadinya kerusakan jaringan dengan cara SC. Pemberian obat dengan IM atau IV lebih beresiko karena cepat terabsorpsi. Pada banyak klien, terutama anak-anak cara ini menimbulkan ketakutan.

3. Pemberian Obat Topikal

Pemberian Obat Kulit Topikal Tujuan pemberian obat topikal :

1. Mempertahankan hidrasi permukaan kulit
2. Melindungi bagian atas kulit
3. Mengurangi iritasi kulit local
4. Membuat anestesi local
5. Mengobati infeksi, abrasi atau iritasi

Peralatan:

1. Agens topikal yang diresepkan (krim, losion, aerosol, spray, bubuk/serbuk, koyo)
2. Baskom yang berisi air hangat, lap, handuk, dan sabun yang tidak mengeringkan
3. Kain perban, plastik penutup, atau plester
4. Hands scoon steril atau sekali pakai
5. Catatan pemberian medikasi

Mencatat KU: hasil dari pemberian obat; Tanggal dan jam pemberian obat, nama obat yang diberikan dan nama perawat yang memberikan obat

Prosedure Kerja :

1. Cuci tangan
2. Jelaskan kepada klien tentang tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan
3. Tinjau kembali, waktu pemberian dan tempat pengolesan obat, perhatikan kondisi kulit klien secara menyeluruh. Cuci area yang sakit, kaji debris dan kulit yang mengering (gunakan sabun yang tidak mengeringkan). Memastikan bahwa obat akan diberikan secara aman dan akurat
4. Pengoles berujung kapas atau spatel lidah. Memberikan dasar untuk menentukan perubahan kondisi kulit dalam menjalani terapi. Kulit harus bersih untuk pengkajian yang benar membuang debris untuk meningkatkan penetrasi obat topical terhadap kulit. Pembersihan dapat menghilangkan tempat hidup mikroorganisme dalam debris. Pembersihan juga membuang sisa-sisa obat sebelumnya sehingga tidak akan terjadi over dosis.
5. Keringkan kulit atau pajanan keudara yang kering. Kelembapan yang berlebihan dapat mengganggu pemerataan agens topical
6. Jika kulit sangat kering dan mengelupas, oleskan agens topical sewaktu kulit masih lembab. mempertahankan kelembapan lapisan kulit
7. Letakkan agens topikal pada sarung tangan jika diindikasikan. Sarung tangan sekali pakai digunakan ketika mengoleskan agens pada lesi kulit
8. Oleskan agens topikal
 - a. Krim, Salep, dan losion berbahan mengandung minyak
 - 1) Letakkan 1-2 sendok teh medikasi pada telapak tangan dan lunakkan dengan menggosok secara cepat diantara dua tangan. Melembutkan agens topical akan memudahkan mengoleskannya pada kulit
 - 2) Medikasi lainnya sedikit dan halus, oleskan secara merata dipermukaan kulit dengan menggunakan usapan yang panjang dan merata dengan mengikuti pertumbuhan rambut. Memastikan penyebaran medikasi yang merata. Mencegah iritasi pada folikel rambut
 - 3) Jelaskan pada klien bahwa kulit akan berminyak setelah diolesi agens topikal. Salep sering mengandung minyak
 - b. Spray Aerosol
 - 1) Baca label sesuai yang dianjurkan untuk pemakaian yang efektif. Mencampur isi dengan propelan untuk memastikan penyebaran spray yang baik dan merata
 - 2) Jika dada atas atau leher terkena spray, beritahu klien untuk memalingkan wajah menjauhi spray. Pegang handuk didepan wajah klien saat penyemprotan obat. Jarak yang tepat menjamin spray mengenai permukaan kulit.
 - 3) Semprotkan medikasi secara merata disekitar daerah yang terkena (pada beberapa kasus spray diberi waktu untuk beberapa detik tertentu)

c. Losion mengandung suspensi

- 1) Kocok botol secara tepat
- 2) Oleskan sedikit losion pada kain perban atau alas dan gunakan pada kulit dengan mengusapkannya secara merata mengikuti arah pertumbuhan rambut kulit
- 3) Jelaskan pada klien bahwa area yang diolesi losion terasa dingin dan kering
- 4) Pastikan bahwa seluruh permukaan kulit mengering
- 5) Tebarkan bagian lipatan kulit seperti diantara jari kaki atau dibawah lengan
- 6) Taburi area kulit secara lembut dengan menggunakan dispenser sehingga area kulit tertutup dengan lapisan serbuk yang lembut dan tipis
- 7) Tutup area kulit dengan membalutnya jika di anjurkan dokter.

4. Pemberian Obat Tetes

Obat tetes merupakan obat yang diberikan dengan cara diteteskan pada daerah lokasi yang akan diberikan. Pemberian obat tetes biasanya dilakukan pada mata, hidung dan telinga.

a. Pemberian obat tetes hidung :

Alat dan bahan :

- 1) Obat yang dibutuhkan
- 2) Pipet
- 3) Bengkok
- 4) Kertas atau tisu

Prosedur kerja:

- 1) Cuci tangan
- 2) Jelaskan kepada klien tentang tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan
- 3) Atur posisi klien sehingga kepala klien lebih rendah daripada bahu. Misalnya : posisi klien dengan duduk dikursi sambil kepala menghadap ke belakang, berbaring dengan kepala ekstensi pada tepi tempat tidur, atau berbaring dengan bantal dibawah bahu dan kepala menghadap.
- 4) Kocok botol obat tetes hidung dan lepaskan penutupnya sebelum digunakan
- 5) Isi pipet dengan obat yang sudah ditentukan
- 6) Masukkan ujung pipet ke salah satu lubang hidung yang tidak diberi obat dengan jari anda
- 7) Tekan pipet perlahan hingga keluar tetesan cairan didalam lubang hidung
- 8) Keluarkan bagian ujung pipet dari lubang hidung dan hirup cairan tersebut secara perlahan, hindari menghirup cairan obat terlalu keras karena hal tersebut dapat membuat cairan obat melewati rongga hidung secara cepat dan masuk kedalam tenggorokan
- 9) Pertahankan posisi kepala tetap tengadah selama 5-10 menit agar obat tidak mengalir keluar
- 10) Bersihkan ujung pipet dengan tisu bersih setelah digunakan dan pasang kembali tutupnya

- 11) Bersihkan hidung menggunakan tisu bersih
- 12) Rapikan dan kembalikan alat ke tempatnya
- 13) Cuci tangan, catat cara, tanggal, dan dosis pemberian obat



Gambar. Pemberian obat tetes hidung

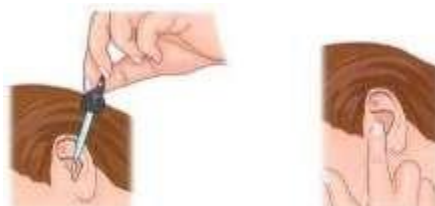
b. Pemberian obat tetes telinga :

Alat dan bahan :

- 1) Obat yang dibutuhkan
- 2) Pipet
- 3) Lidi kapas steril
- 4) Korentang steril
- 5) Bengkok
- 6) Lap atau tisu

Prosedurkerja:

- 1) Cuci tangan
- 2) Jelaskan kepada klien tentang tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan
- 3) Atur posisi klien sehingga berbaring dalam posisi miring dengan telinga yang sakit menghadap ke atas
- 4) Letakan handuk dibawah bahu klien, lalu bersihkan liang telinga dengan kapas lidi
- 5) Isi pipet dengan obat yang dibutuhkan
- 6) Luruskan lubang telinga dengan menarik daun telinga ke atas atau ke belakang (pada orang dewasa) atau ke bawah pada anak
- 7) Teteskan obat pada dinding saluran untuk mencegah terhalang oleh gelembung udara. Sesuaikan jumlah obat dengan dosis yang telah direncanakan. Apabila obat berupa obat salep, ambil kapas lidi dan oleskan salep pada kapas lidi tersebut. Lalu, masukkan atau oleskan obat pada liang telinga.
- 8) Bersihkan bekas obat dengan kapas bulat, pertahankan posisi kepala sekitar 2-3 menit.
- 9) Rapikan klien dan lingkungan, bereskan alat dan kembalikan ke tempat semula.
- 10) Cuci tangan, catat tanggal dan dosis pemberian.



Gambar. Pemberian Tetes Telinga

c. Pemberian obat tetes mata :

Alat dan bahan :

- 1) Obat yang dibutuhkan
- 2) Pipet
- 3) Bengkok
- 4) Kapas
- 5) sarung tangan

Prosedur kerja :

- 1) Cuci tangan
- 2) Jelaskan kepada klien tentang tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan
- 3) Atur posisi klien sehingga kepala klien menengadah dengan posisi perawat disamping klien
- 4) Gunakan sarung tangan
- 5) Bersihkan daerah kelopak dan bulu mata dengan kapas lembab dari sudut mata ke arah hidung. Jika terlalu kotor basuh dengan air hangat
- 6) Buka kelopak mata bagian bawah dengan jari telunjuk kiri
- 7) Teteskan obat mata pada permukaan konjungtiva kelopak mata bagian bawah. Anjurkan klien untuk menutup mata secara perlahan. Jika obat mata berbentuk salep, pegang aplikator salep di atas pinggir kelopak mata. Pijat tube sehingga obat keluar, kemudian berikan obat di kelopak mata bawah dari kamus dalam ke kamus luar. Anjurkan klien untuk menutup dan mengejapkan kelopak mata.
- 8) Bersihkan sisa obat dengan kapas basah
- 9) Bereskan alat, lepas sarung tangan, dan kembalikan peralatan ke tempatnya
- 10) Cuci tangan, catat nama obat, jumlah, waktu, dan tempat pemberian



Gambar. Memberikan tetes dan salep mata

d. Pemberian obat melalui anus/rektal

Pengertian : Memberikan obat-obat tertentu melalui anus atau rektum

Dengan cara : mengoleskan obat dan memasukkan obat suppositoria

Tujuan mengoleskan obat : sebagai pengobatan atau mengurangi rasa sakit dilakukan pada klien : dengan hemoroid, luka/ fisura pada anus

Memasukkan Suppositoria Rektal

a. Tujuan:

Pengobatan, mengurangi rasa sakit, otot pernafasan menjadi kendur, feses menjadi lunak dan buang air besar menjadi terangsang.

b. Dilakukan pada klien:

Penyakit hemoroid misalnya obat ultraprokt, anusol

Penyakit asma bronkhial, misalnya obat aminopilin, konstipasi misalnya profenit Aminopilin supositoria bekerja secara sistemik untuk mendilatasi bronkhial respiratori, dulkolak untuk meningkatkan defekasi yang bekerja secara lokal. Perawat harus memperhatikan terutama pada penempatan supositoria dengan benar pada dinding mukosa rektal, melewati spinter anal interna sehingga supositoria tidak akan dikeluarkan

c. Kontraindikasi Klien yang mengalami pembedahan atau perdarahan rektal tidak boleh diberikan supositoria.

d. Peralatan:

- 1) Supositoria rektal . (*supositoria harus disimpan dalam lemari es agar tidak meleleh*)
- 2) Jeli pelumas (larut air)
- 3) Sarung tangan sekali pakai
- 4) Tisu
- 5) Duk
- 6) Catatan pemberian obat

e. Prosedure Kerja

- 1) Tinjau ulang nama obat,dosis dan rute pemberian. Meyakinkan bahwa obat akandiberikan secara aman dan akurat
- 2) Minta klien untuk melakukan posisi sim (sims) dengan kaki atas fleksi ke depan.(Memajukan anus dan membantu klien merilekskan spinter anal eksternal)
- 3) Pertahankan klien tertutup duk dengan hanya area anal yang terpajan. (Penutupan klien mempertahankan privasi dan memudahkan relaksasi)
- 4) Periksa kondisi anus eksternal dan palpasi dinding rektal. Lepaskan sarung tangan dengan menariknya kedalam dan menempatkannya dalam wadah yang tepat. (Mengkaji adanya perdarahan rektal aktif)
- 5) Kenakan sepasang sarung tangan baru.(Mengurangi penularan infeksi)
- 6) Lepaskan supositoria dari wadahnya dan beri pelumas pada sekitar ujung dengan jeli. Beri pelumas sarung tangan pada jari telunjuk tangan dominan anda. (Pelumasan mengurangi friksi saat supositoria masuk ke rektum)
- 7) Minta klien untuk merilekskan spinter anal. (Mendorong supositoria melalui spinngter yang konstiksi menyebabkan nyeri)

- 8) Regangkan bokong klien dengan tangan nondominan anda. Dengan jari telunjuk yang tersarungi, masukkan supositoria dengan perlahan melalui anus, melalui spinter anal internal dan mengenai dinding rektal : masukkan seluruh jari pada orang dewasa, kira-kira 5 cm pada anak-anak dan bayi. (Supositoria harus ditempatkan mengenai mukaosa rektal untuk absorpsi dan kerja terapeutik).
- 9) Tarik jari anda dan bersihkan area anal klien. (Memberikan klien rasa nyaman)
- 10) Instruksikan klien ntk tetap berbaring telentang atau miring selama 5 menit. (Mencegah keluarnya supositoria)
- 11) Bila supositoria mengandung laksatif atau pelunak feses ,tempatkan tombol pemanggil dalam jangkauan klien sehingga ia dapat mencari bantuan untuk mengambil pispot atau kamar mandi.(Mampu untk memanggil bantuan memberikan klien rasa kontrol terhadap eliminasi)
- 12) Membuka sarung tangan membalik bagian dalam keluar dan buang dalam wadah yang tepat. (Membuang sarng tangan dengan cara ini mengurangi pemindahan mikroorganisme)



Gambar. Pemberian Obat Supositoria

Kewaspadaan perawat

Mungkin perlu merapatkan bokong klien sebentar untuk menahan dorongan defekasi

Respon klien yang membutuhkan tindakan dengan segera

1. Reaksi Alergi :

Tetap tenang dan tenangkan klien. Cari bantuan tetapi tetap bersama klien. Mulai pemberian oksigen bila klien merasa sesak nafas. Ukur tanda vital sesuai kebutuhan Ikuti kebijakan lembaga mengenai reaksi alergi

2. Respons vagal refleks (melambatnya frekuensi jantung) sebagai akibat stimulasi rektal berlebihan:

Tetap tenang dan tenangkan klien. Tetap bersama klien ,cari bantuan dan berikan pelumas tambahan.

3. Klien melaporkan rasa terbakar atau nyeri pada insersi: Berikan pelumas tambahan

4. Klien menolak obat:

Identifikasi alasan klien menolak obat,bila obat disembunyikan dokumentasikan penolakan.Bila obat penting dokumentasikan penolakan dan beritahu dokter.

PRINSIP 12 BENAR CARA PEMBERIAN OBAT

1. Benar obat Benar
2. dosis Benar
3. Benar cara pemberian
4. Benar waktu
7. Benar pendidikan kesehatan
8. Hak klien untuk menolak
9. Benar pengkajian
10. Benar evaluasi
11. Benar reaksi terhadap makanan
12. Benar reaksi dengan obat lain

1.1. SOP Prosedur Tindakan Pemberian Obat

FASE PRAINTERAKSI	
1	Mengidentifikasi kebutuhan/indikasi klien
2	Mencuci tangan
3	Menyiapkan alat
FASE ORIENTASI	
4	Mengucapkan salam & memperkenalkan diri
5	Menjelaskan tujuan prosedur tindakan
6	Menanyakan persetujuan klien untuk dilakukan tindakan
FASE KERJA	
7	Menjaga privasi klien
8	Memakai sarung tangan
9	Mengatur posisi klien
10	Memasang pengalas
11	Mendekatkan alat
	Injeksi Intramuskuler (IM)
12	Mengambil obat sesuai dengan dosis yang akan diberikan. Letakan pada bak injeksi
13	Menentukan area penyuntikan
14	Melakukan desinfeksi pada area yang ditentukan
15	Melepaskan tutup jarum dengan menggunakan teknik satu tangan
16	Mengangkat kulit sedikit dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri, menusukkan jarum dengan sudut 90° dari kulit (tegak lurus dengan permukaan kulit)
17	Lakukan aspirasi untuk menentukan tidak mengenai pembuluh darah, jika tidak ada darah masukkan obat secara perlahan-lahan
18	Memasukkan obat pelan-pelan
19	Mencabut jarum sambil menekan tempat tusukan dengan kapas alkohol
20	Menutup jarum dengan teknik satu tangan
21	Mengambil perlak dan pengalas
22	Melepas sarung tangan
23	Mengembalikan klien pada posisi yang nyaman

SOP	Injeksi Intravena (IV)
24	Menyiapkan obat yang akan disuntikkan
25	Mencari lokasi penyuntikan dan bebaskan dari pakaian (cari daerah yang terlihat jelas venanya)
26	Memasang perlak dan alas dibawah daerah yang akan disuntik
27	Membendung area di atas vena yang akan diinjeksi dengan menggunakan torniquet
28	Melakukan desinfeksi pada area yang ditentukan
29	Meregangkan kulit sedikit dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri, tusukkan jarum ke dalam vena dengan lubang jarum menghadap keatas, dengan sudut 20°
30	Lakukan aspirasi untuk mengetahui apakah jarum sudah masuk kedalam vena yang ditandai dengan darah masuk kedalam tabung spuit (jika tidak ada darah masukkan sedikit lagi jarum sampai terasa masuk vena).
31	Buka karet pembendung (torniquet) dan anjurkan klien membuka kepalan tangannya, masukkan obat secara perlahan jangan teralucepat
32	Meletakan kapas alkohol yang baru diatas jarum, cabut jarum dari kulit secara dengan agak cepat
	Injeksi Intracutan (IC)
33	Menentukan area penyuntikan
34	Melakukan desinfeksi pada area yang ditentukan
35	Melepaskan tutup jarum dengan menggunakan teknik satu tangan
36	Memasukkan jarum dengan sudut 15°-20°, dengan tangan yang tidak dominan meregangkan area sekitar penyuntikan*
37	Memasukkan obat pelan-pelan sampai tampak bulatan menonjol
38	Menarik jarum dan jangan melakukan masage. Tandai bulatan yang menonjol dengan pena serta menganjurkan klien untuk tidak menekan daerah benjolan.
39	Menutup jarum dengan teknik satu tangan
40	Mengambil perlak dan pengalas
41	Melepas sarung tangan
42	Mengembalikan klien pada posisi yang nyaman
	Injeksi Subkutan (SC)
43	Menentukan area penyuntikan
44	Melakukan desinfeksi pada area yang ditentukan
45	Melepaskan tutup jarum dengan menggunakan teknik satu tangan
46	Memasukkan jarum dengan sudut 45°, dengan tangan yang tidak dominan meregangkan area sekitar penyuntikan
47	Memasukkan obat pelan-pelan
48	Mencabut jarum sambil menekan tempat tusukan
49	Menutup jarum dengan teknik satu tangan
50	Melepas sarung tangan
51	Mengembalikan klien pada posisi yang nyaman

	Obat Supositoria
52	Membantu klien pada posisi Sim, jaga agar hanya pada bagian anus saja yang terbuka
53	Keluarkan supositoria dari bungkusnya, lumasi ujung supositoria dan tangan yang dominan dengan dengan jelly atau pelumas larut air
54	Minta klien tarik nafas dalam dengan perlahan melalui mulut agar sfingter anus relaksasi
55	Retraksi bokong (merenggangkan glutea) dengan tangan tidak dominan. Masukkan supositoria dengan perlahan melalui anus melalui sfingter anal internal dan ke arah dinding rektum, 10 cm pada dewasa 5 cm pada anak dan bayi.
56	Menarik jari tangan dan membersihkan area sekitar anal dengan tisu
57	Menganjurkan klien untuk menahan ± 15 menit agar obat tidak keluar sehingga bereaksi optimal
58	Melepas sarung tangan
FASE TERMINASI	
59	Merapikan klien dan alat
60	Mengevaluasi respon klien
61	Mencuci tangan
62	Mengucapkan salam
63	Mendokumentasikan tindakan yang telah dilakukan

BAB 13

PERAWATAN UNTUK PENYANDANG DISABILITAS

13.1. Pengertian:

Perawatan disabilitas adalah serangkaian layanan atau intervensi yang diberikan kepada individu dengan keterbatasan fisik, mental, sensorik, atau intelektual untuk mendukung kualitas hidup mereka. Perawatan ini mencakup aspek medis, sosial, psikologis, dan lingkungan untuk memastikan kesejahteraan individu tersebut.

13.2. Tujuan:

1. Memastikan kesehatan fisik dan mental yang optimal bagi penyandang disabilitas.
2. Membantu individu menjalani kehidupan yang mandiri sebisa mungkin.
3. Mengurangi ketergantungan pada orang lain dengan memberikan alat bantu atau pelatihan.
4. Meningkatkan partisipasi sosial dan kesejahteraan emosional.
- 5.

13.3. Faktor Penyebab Disabilitas

Ada beberapa faktor yang dikaitkan dengan penyebab seseorang mengalami disabilitas, diantaranya sebagai berikut :

1. kelainan bawaan lahir yang mempengaruhi fungsi dan struktur organ tubuh, seperti kelainan kromosom (down syndrome), kelainan gen tunggal yang dapat menyebabkan duchanne muscular dystrophy, dan kelainan yang disebabkan oleh paparan infeksi atau zat berbahaya (alkohol dan rokok) selama masa kehamilan
2. Akibat cedera, misalnya cedera tulang belakang dan cedera otak traumatis
3. Penyakit kronis, seperti diabetes, stroke dan penyakit kardiovaskuler
4. Gangguan spektrum autisme dan ADHD(Attention Defisit Hiperaktiviti Disorder) yang muncul sejak masa kanak-kanak

13.4. Jenis-Jenis Disabilitas

1. Disabilitas kognitif adalah keterbatasan pada fungsi intelektual dan kapasitas otak seseorang sehingga mengakibatkan keterlambatan atau kemunduran dalam tahap perkembangan seperti gangguan spektrum autisme dan gangguan ADHD
2. Disabilitas fisik adalah ,keterbatasan pada fungsi tubuh seperti tunadaksa (gangguan fisik dan gerak), tunanetra (gangguan penglihatan), tunarungu (gangguan pendengaran) dan tuna wicara (gangguan berbicara)
3. Disabilitas sensorik adalah keterbatasan pada fungsi panca indra seperti gangguan penglihatan(tunanetra), gangguan rungu (pendengaran) dan gangguan tunawicara (berbicara)
4. Disabilitas mental adalah keterbatasan akibat gangguan pada fungsi psikologis, pikiran, , perilaku dan emosi seperti bipolar, gangguan kecemasan dan depresi

13.5. Jenis Perawatan Disabilitas:

1. Perawatan Fisik: Melibatkan bantuan dengan aktivitas sehari-hari (ADL) seperti mandi, berpakaian, makan, atau mobilitas. Ini juga mencakup terapi fisik untuk memperkuat otot dan menjaga mobilitas.
2. Perawatan Mental dan Emosional: Penyandang disabilitas sering membutuhkan dukungan psikologis untuk mengatasi stres, kecemasan, atau depresi. Konseling dan terapi psikologis adalah bagian penting dari perawatan ini.
3. Dukungan Sosial: Termasuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan aksesibilitas dalam kehidupan sehari-hari seperti akses ke tempat kerja, transportasi, dan fasilitas publik.

4. Perawatan Kesehatan: Pengawasan medis rutin untuk menangani kondisi kesehatan yang mungkin lebih rentan pada penyandang disabilitas, termasuk pengobatan, terapi okupasi, atau perawatan khusus terkait kondisi medis mereka.
5. Penggunaan Alat Bantu: Penyediaan dan pelatihan penggunaan alat bantu seperti kursi roda, tongkat, prostesis, alat bantu dengar, dan perangkat lainnya untuk mendukung mobilitas dan interaksi sosial.

13.6. Prinsip Perawatan Disabilitas:

1. Person-Centered Care: Fokus pada kebutuhan dan preferensi individu.
2. Autonomi dan Independensi: Mendorong kemandirian sebisa mungkin.
3. Inklusi: Memastikan individu berpartisipasi dalam komunitas dan kehidupan sosial.
4. Aksesibilitas: Menyediakan akses ke layanan, fasilitas, dan ruang publik tanpa hambatan fisik atau sosial.
5. Kolaborasi Multidisiplin: Tim perawat sering mencakup dokter, terapis, pekerja sosial, dan perawat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmadi. 2008. Teknik Prosedural Keperawatan Konsep Aplikasi Kebutuhan Dasar Klien. Jakarta : Salemba Medika.
- Aziz, Alimul H.. 2008. Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia; Aplikasi Konsep dan Proses Keperawatan; Buku 2. Jakarta : Salemba Medika.
- Aprilianto,Dodik dkk. 2018. Kebutuhan Dasar Manusia SMA/MAK Kls XI. Yogyakarta : Andi.
- Barnest., Vichi Vine., 1989. Clinical Skill and Assessment Techniques in Nursing Practice. London : Scoth Foreman and Company.
- Belland, Kethleen Hoerth & Wells, Marry Ann. 1986. Clinical Nursing Prosedures. California: Jones and Battlett Publisher
- Carpenito, L.J. 2007. Handbook of Nursing Diagnosis. Toronto: Lippincot.
- Pratiwi, Eryina Pransiska Rindu . 2024. Asisten Keperawatan dan Caregiver, edisi 2. Bogor: Yudhistira
- Kozier., Barbara. 1995. Fundamental of Nursing Concept, Process and Practice. Fith Edition. Philadelphia : Addison–Wesley Publishing Company.
- Lestari, Yeni dkk. 2018. Ketrampilan Dasar Tindakan Keperawatan SMA/MAK Kls XI, Yogyakarta: Andi
- Lestari, Yeni dkk. 2018. Ketrampilan Dasar Tindakan Keperawatan SMA/MAK Kls XII, Yogyakarta: Andi
- Lynn, P. B.. 2011. Taylor’s Clinical Nursing Skill; A Nursing Process Approach. Third Edition. Philadelphia: Lippincott William & Wilkins.
- Mansjoer, A. 2010. Kapita Selekt Kedokteran, edisi 4. Jakarta : Media Aesculapius. FKUI.
- Meeker, B. & Rhoads, J. 2011. Davis Guide To Clinical Nursing Skills. Philadelphia : F A Davis Co.
- Perry, Potter. 2005 Fundamental Keperawatan Volume 2 edisi 4. Jakarta : EGC
- Saputra, Lyndon. 2013. Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia. Jakarta : Binarupa Aksara Publisher
- Tim Penyusun Pusdiklatnakes. 2013. Pedoman Praktik Laboratorium Kebutuhan Dasar Manusia II. Jakarta : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI
- Wijayanti, Dwi. 2020. Keterampilan Dasar Tindakan Keperawatan. Jakarta: Bumi Aksara
- Wijayanti, Dwi. 2020. Kebutuhan Dasar Manusia SMA / MAK Kls XI. Jakarta: Bumi Aksara
- Zakaria, achmad, dkk. 2016. Buku Panduan Keterampilan Dasar dalam Keperawatan. Jombang : Fakultas Ilmu Kesehatan UNIPDU
- Zega, Wira Pratama.2019.Keterampilan Dasar Tindakan Keperawatan Program Keahlian Keperawatan. Jakarta : EGC

PROFIL PENULIS



Dewi Rasilian, S.Kep.,Ns adalah Ketua Kompetensi Keahlian Layanan Penunjang Keperawatan dan Caregiving (LPKC) di SMK Negeri 1 Pakong Pamekasan. Menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Keperawatan tahun 2009 dan profesi Ners tahun 2011 di Sekolah tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang (ICME). Pada tahun 2022 mendapatkan sertifikat profesi guru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Penulis pernah menjabat Kepala bengkel Kompetensi Keahlian Layanan Penunjang Keperawatan dan Caregiving (LPKC) di SMKN 1 Pakong tahun 2022 dan membina peserta didik untuk kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Jawa Timur. Penulis bisa dihubungi di email dewirasilian@gmail.com.



Wawan Kurniawan Rasul, S.Kep.,Ns adalah Guru Produktif Kompetensi Keahlian Layanan Penunjang Keperawatan dan Caregiving (LPKC) di SMK Negeri 1 Pakong Pamekasan. Menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Keperawatan tahun 2013 dan profesi Ners tahun 2014 di Universitas Kediri. Penulis pernah menjabat Ketua Kompetensi Keahlian Layanan Penunjang Keperawatan dan Caregiving (LPKC) di SMKN 1 Pakong tahun 2015 dan Penulis juga aktif di kegiatan Ekstrakurikuler Pencak Silat PSHT. Penulis bisa dihubungi di email wawankr1922@gmail.com.



Nur Sriwulandari, S.S.T.Keb., Gr adalah seorang Guru Produktif Kompetensi Keahlian Layanan Penunjang Keperawatan dan Caregiving (LPKC) di SMK Negeri 1 Pakong Pamekasan. Menyelesaikan Pendidikan DIV BIDAN PENDIDIK tahun 2013. Pada tahun 2023 mendapatkan sertifikat profesi guru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Penulis juga menjabat Kepala bengkel Kompetensi Keahlian Layanan Penunjang Keperawatan dan Caregiving (LPKC) di SMKN 1 Pakong tahun dan membina peserta didik untuk kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022. Penulis bisa dihubungi di email nursriwulandari22@gmail.com.



Milda Laila Taufik, S.Kep., Ns. Adalah Guru Kompetensi Keahlian Layanan Penunjang Keperawatan dan Caregiving (LPKC) di SMKN 1 Pakong Pamekasan. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Keperawatan tahun 2016 dan pendidikan profesi Ners pada tahun 2017 di Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang (UNIPDU). Penulis mendapatkan sertifikat profesi guru pada tahun 2022 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Penulis pernah membina peserta didik untuk kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Jawa Timur. Penulis bisa dihubungi di email mildataufik9@gmail.com.

